

Tabagisme

Dr Tlili

Maitre de conférence B en pneumo-
phtisiologie

Objectifs

- Reconnaître l'ampleur du fléau
- Connaître la composition de la fumée du tabac
- Reconnaître les méfaits du tabagisme
- Évaluer la dépendance au tabagisme
- Connaître les grands axes thérapeutiques
- Savoir prévenir le tabagisme

plan

- INTRODUCTION
- ÉPIDÉMIOLOGIE
- LA FUMÉE DU TABAC
- EFFETS DU TABAC SUR LA SANTÉ
- TABAGISME PASSIF
- TABAGISME FÉMININ
- DÉPENDANCE
- SYNDROME DE SEVRAGE
- BÉNÉFICES DE L'ARRÊT DU TABAGISME
- PRISE EN CHARGE DE SEVRAGE TABAGIQUE
- PRÉVENTION ET LUTTE ANTITABAC
- CONCLUSION
- BIBLIOGRAPHIE

Introduction

Le tabac est un produit psychoactif, élaboré à partir de feuilles séchées de plantes de tabac commun (*Nicotiana tabacum*), originaire d'Amérique centrale.

Son usage s'est largement répandu dans le monde entier à la suite de la découverte de l'Amérique.

Sa commercialisation est souvent un monopole d'état et soumise à des taxes qui varient fortement selon les pays.

Le tabac génère une forte dépendance et sa consommation est responsable de 8 millions de décès/an dans le monde, ainsi que de nombreuses maladies.

Introduction

Le tabac est consommé de plusieurs manières :

- Fumée** +++++ (cigarette, pipe, cigare,...) en vrac à rouler, en joint c'est-à-dire mélangé à du cannabis, mélangé avec de la mélasse parfumée dans un narguilé, etc.)
 - Prisée** (par inhalation nasale)
 - Chiquée** : par mastication ou en plaçant une boulette entre lèvre et gencive.
- Toutes ces formes sont aussi dangereuses et on constate un fort attachement des utilisateurs à leur marque de tabac.

Epidémiologie

- Selon l'OMS
- 1.3 milliards de fumeurs
- 1.7 milliard en 2020 - 2025.
- Hommes: 1 milliard
- 35% dans les pays développés
- 50% dans les pays en développement
- Femmes: 250 millions
- 22% dans les pays développés
- 9% dans les pays en développement

Composition

- Parmi les 4000 composants de la fumée du tabac, on retiendra principalement :
 - 1) **La nicotine** : qui engendre la dépendance physique et psychique. Elle est responsable d'effets vasculaires et neurologiques.
 - 2) **Les cancérigènes** : au moins 80 produits cancérigènes, goudrons +++, cancérigènes et irritants.
 - 3) **Les irritants** : tels les aldéhydes, les phénols ou l'acroléine... ont une action sur l'appareil respiratoire
 - 4) **Le CO** : effets cardiovasculaires.
- NB/Il est à noter que les cigarettes algériennes contiennent une forte teneur en produits toxiques dépassant largement les normes européennes.

La dépendance

- La dépendance physique ou pharmacologique** est directement liée à la nicotine
- La dépendance psychologique** est liée aux « effets positifs » que le fumeur associe à la cigarette.
- La dépendance comportementale (ou sociale)** est liée aux situations répétées associées à la cigarette et qui peuvent déclencher l'envie « réflexe » de fumer

Effets du tabac sur la santé

Tableau 1 : Principales complications du tabagisme actif	
Type de complication	Caractéristiques des complications
Cancers	Cancers : le plus fréquent, il se situe dans 25 % des cas Pneumonie : risque accru de 10 fois Mortel : risque accru de 10 fois
Cardiovasculaires	Infarctus du myocarde : risque accru de 2 à 4 fois Mortel : risque accru de 2 à 4 fois
Respiratoires	Emphysème chronique obstructif (EPOC) Bronchite chronique
Reproduction	Infertilité chez l'homme Mortinets, fausses couches
Diabetes	Risque accru de diabète de type 2
Poids et phénotype	Obésité, augmentation de la pression artérielle, risque accru de diabète
Infarctus	Infarctus coronariens
Alcoolisme	Risque accru de consommation d'alcool, risque accru de dépendance

Dépendance

- C'est l'impossibilité de s'abstenir de consommer avec poursuite du comportement en dépit de la connaissance de ces effets délétères :
 - Dépendance gestuelle
 - Dépendance psycho comportementale
 - Dépendance pharmacologique
- En pratique et pour évaluer la dépendance on utilise un questionnaire : test de Fagerström

Syndrome de Sevrage tabagique

- Présence d'au moins 4 des facteurs suivants :
- Humeur dépressive.
 - Insomnie.
 - Irritabilité, frustration, colère.
 - Anxiété.
 - Difficulté de concentration.
 - Agitation.
 - Ralentissement du poids.
 - Augmentation de l'appétit et/ou prise de poids rapide.
- Ces signes causent une souffrance clinique et parfois une altération du comportement familial ou social.
- Ils ne sont pas expliqués par une maladie mentale.

Bénéfices de l'arrêt du tabagisme

Arrêter de fumer	Après 10 minutes d'arrêt, la tension artérielle diminue et les palpitations disparaissent.
Après 24 heures	Après 24 heures d'arrêt, la capacité de guérison des plaies augmente.
Après 48 heures	Après 48 heures d'arrêt, les symptômes de dépendance diminuent.
Après 72 heures	Après 72 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 96 heures	Après 96 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 120 heures	Après 120 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 144 heures	Après 144 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 168 heures	Après 168 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 192 heures	Après 192 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 216 heures	Après 216 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 240 heures	Après 240 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 264 heures	Après 264 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 288 heures	Après 288 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 312 heures	Après 312 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 336 heures	Après 336 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 360 heures	Après 360 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 384 heures	Après 384 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 408 heures	Après 408 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 432 heures	Après 432 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 456 heures	Après 456 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 480 heures	Après 480 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 504 heures	Après 504 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 528 heures	Après 528 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 552 heures	Après 552 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 576 heures	Après 576 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 600 heures	Après 600 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 624 heures	Après 624 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 648 heures	Après 648 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 672 heures	Après 672 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 696 heures	Après 696 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 720 heures	Après 720 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 744 heures	Après 744 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 768 heures	Après 768 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 792 heures	Après 792 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 816 heures	Après 816 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 840 heures	Après 840 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 864 heures	Après 864 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 888 heures	Après 888 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 912 heures	Après 912 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 936 heures	Après 936 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 960 heures	Après 960 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 984 heures	Après 984 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1008 heures	Après 1008 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1032 heures	Après 1032 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1056 heures	Après 1056 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1080 heures	Après 1080 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1104 heures	Après 1104 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1128 heures	Après 1128 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1152 heures	Après 1152 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1176 heures	Après 1176 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1200 heures	Après 1200 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1224 heures	Après 1224 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1248 heures	Après 1248 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1272 heures	Après 1272 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1296 heures	Après 1296 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1320 heures	Après 1320 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1344 heures	Après 1344 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1368 heures	Après 1368 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1392 heures	Après 1392 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1416 heures	Après 1416 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1440 heures	Après 1440 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1464 heures	Après 1464 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1488 heures	Après 1488 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1512 heures	Après 1512 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1536 heures	Après 1536 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1560 heures	Après 1560 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1584 heures	Après 1584 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1608 heures	Après 1608 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1632 heures	Après 1632 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1656 heures	Après 1656 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1680 heures	Après 1680 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1704 heures	Après 1704 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1728 heures	Après 1728 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1752 heures	Après 1752 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1776 heures	Après 1776 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1800 heures	Après 1800 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1824 heures	Après 1824 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1848 heures	Après 1848 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1872 heures	Après 1872 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1896 heures	Après 1896 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1920 heures	Après 1920 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1944 heures	Après 1944 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1968 heures	Après 1968 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 1992 heures	Après 1992 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2016 heures	Après 2016 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2040 heures	Après 2040 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2064 heures	Après 2064 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2088 heures	Après 2088 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2112 heures	Après 2112 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2136 heures	Après 2136 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2160 heures	Après 2160 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2184 heures	Après 2184 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2208 heures	Après 2208 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2232 heures	Après 2232 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2256 heures	Après 2256 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2280 heures	Après 2280 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2304 heures	Après 2304 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2328 heures	Après 2328 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2352 heures	Après 2352 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2376 heures	Après 2376 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2400 heures	Après 2400 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2424 heures	Après 2424 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2448 heures	Après 2448 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2472 heures	Après 2472 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2496 heures	Après 2496 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2520 heures	Après 2520 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2544 heures	Après 2544 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2568 heures	Après 2568 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2592 heures	Après 2592 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2616 heures	Après 2616 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2640 heures	Après 2640 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2664 heures	Après 2664 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2688 heures	Après 2688 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2712 heures	Après 2712 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2736 heures	Après 2736 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2760 heures	Après 2760 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2784 heures	Après 2784 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2808 heures	Après 2808 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2832 heures	Après 2832 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2856 heures	Après 2856 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2880 heures	Après 2880 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2904 heures	Après 2904 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2928 heures	Après 2928 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2952 heures	Après 2952 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 2976 heures	Après 2976 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3000 heures	Après 3000 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3024 heures	Après 3024 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3048 heures	Après 3048 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3072 heures	Après 3072 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3096 heures	Après 3096 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3120 heures	Après 3120 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3144 heures	Après 3144 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3168 heures	Après 3168 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3192 heures	Après 3192 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3216 heures	Après 3216 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3240 heures	Après 3240 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3264 heures	Après 3264 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3288 heures	Après 3288 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3312 heures	Après 3312 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3336 heures	Après 3336 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3360 heures	Après 3360 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3384 heures	Après 3384 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3408 heures	Après 3408 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3432 heures	Après 3432 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3456 heures	Après 3456 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3480 heures	Après 3480 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3504 heures	Après 3504 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3528 heures	Après 3528 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3552 heures	Après 3552 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3576 heures	Après 3576 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3600 heures	Après 3600 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3624 heures	Après 3624 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3648 heures	Après 3648 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3672 heures	Après 3672 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3696 heures	Après 3696 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3720 heures	Après 3720 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3744 heures	Après 3744 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3768 heures	Après 3768 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3792 heures	Après 3792 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3816 heures	Après 3816 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3840 heures	Après 3840 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3864 heures	Après 3864 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3888 heures	Après 3888 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3912 heures	Après 3912 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3936 heures	Après 3936 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3960 heures	Après 3960 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 3984 heures	Après 3984 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4008 heures	Après 4008 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4032 heures	Après 4032 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4056 heures	Après 4056 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4080 heures	Après 4080 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4104 heures	Après 4104 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4128 heures	Après 4128 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4152 heures	Après 4152 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4176 heures	Après 4176 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4200 heures	Après 4200 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4224 heures	Après 4224 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4248 heures	Après 4248 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4272 heures	Après 4272 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4296 heures	Après 4296 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4320 heures	Après 4320 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4344 heures	Après 4344 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4368 heures	Après 4368 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4392 heures	Après 4392 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4416 heures	Après 4416 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4440 heures	Après 4440 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4464 heures	Après 4464 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4488 heures	Après 4488 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4512 heures	Après 4512 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4536 heures	Après 4536 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4560 heures	Après 4560 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4584 heures	Après 4584 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4608 heures	Après 4608 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4632 heures	Après 4632 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4656 heures	Après 4656 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4680 heures	Après 4680 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4704 heures	Après 4704 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4728 heures	Après 4728 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4752 heures	Après 4752 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4776 heures	Après 4776 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4800 heures	Après 4800 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4824 heures	Après 4824 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4848 heures	Après 4848 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4872 heures	Après 4872 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4896 heures	Après 4896 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4920 heures	Après 4920 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4944 heures	Après 4944 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4968 heures	Après 4968 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 4992 heures	Après 4992 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5016 heures	Après 5016 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5040 heures	Après 5040 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5064 heures	Après 5064 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5088 heures	Après 5088 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5112 heures	Après 5112 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5136 heures	Après 5136 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5160 heures	Après 5160 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5184 heures	Après 5184 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5208 heures	Après 5208 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5232 heures	Après 5232 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5256 heures	Après 5256 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5280 heures	Après 5280 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5304 heures	Après 5304 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5328 heures	Après 5328 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5352 heures	Après 5352 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5376 heures	Après 5376 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5400 heures	Après 5400 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5424 heures	Après 5424 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5448 heures	Après 5448 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5472 heures	Après 5472 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5496 heures	Après 5496 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5520 heures	Après 5520 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5544 heures	Après 5544 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5568 heures	Après 5568 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5592 heures	Après 5592 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5616 heures	Après 5616 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5640 heures	Après 5640 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5664 heures	Après 5664 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5688 heures	Après 5688 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5712 heures	Après 5712 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5736 heures	Après 5736 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5760 heures	Après 5760 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5784 heures	Après 5784 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5808 heures	Après 5808 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5832 heures	Après 5832 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5856 heures	Après 5856 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5880 heures	Après 5880 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5904 heures	Après 5904 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5928 heures	Après 5928 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5952 heures	Après 5952 heures d'arrêt, le risque de complications diminue.
Après 5976 heures	Après 5976 heures d'arrêt, le risque de complications dim

Objectifs

- Reconnaître l'ampleur du fléau
- Connaître la composition de la fumée du tabac
- Reconnaître les méfaits du tabagisme
- Evaluer la dépendance au tabagisme
- Connaître les grands axes thérapeutiques
- Savoir prévenir le tabagisme

plan

1. INTRODUCTION
2. EPIDEMIOLOGIE
3. LA FUMEE DU TABAC
4. EFFETS DU TABAC SUR LA SANTE
5. TABAGISME PASSIF
6. TABAGISME FEMININ
7. DEPENDANCE
8. SYNDROME DE SEVRAGE
9. BENEFICES DE L'ARRET DU TABAGISME
10. PRISE EN CHARGE DE SEVRAGE TABAGIQUE
11. PREVENTION ET LUTTE ANTITABAC
12. CONCLUSION
13. BIBLIOGRAPHIE

Introduction

Le tabac est un produit psychoactif, élaboré à partir de feuilles séchées de plantes de tabac commun (*Nicotiana tabacum*), originaire d'Amérique centrale.

Son usage s'est largement répandu dans le monde entier à la suite de la découverte de l'Amérique.

Sa commercialisation est souvent un monopole d'état et soumise à des taxes qui varient fortement selon les pays.

Le tabac génère une forte dépendance et sa consommation est responsable de 8 millions de décès/an dans le monde, ainsi que de nombreuses maladies.

Introduction

- Le tabac n'est connu en Europe que depuis la découverte de l'Amérique à la fin du 15^{ème} siècle. Il a d'abord été introduit comme médicament puis a été consommé en prise ou fumé dans une pipe.
- Ce n'est qu'au 19^{ème} siècle qu'il va se présenter sous la forme du cigare et de cigarette.
- Tous les tabacs appartiennent au genre « Nicotiana » ; nom créé en 1565 en l'honneur de Jean Nicot, considéré comme l'un des pères de cette plante en France.

Introduction

Le tabac est consommé de plusieurs manières :

- **Fumée** ++++++(cigarette, pipe, cigare,...) en vrac à rouler, en joint c'est-à-dire mélangé à du cannabis, mélangé avec de la mélasse parfumée dans un narguilé, etc.)
- **Prisée** (par inhalation nasale)
- **Chiquée** : par mastication ou en plaçant une boulette entre lèvre et gencive.

Toutes ces formes sont aussi dangereuses et on constate un fort attachement des utilisateurs à leur marque de tabac.

Différentes formes de tabac fumé

- Les cigarettes industrielles.
- Le tabac à rouler , à chiquer.
- Cigares et pipes.
- La pipe à eau, ou narguilé, ou chicha.



Epidémiologie

- **Selon l'OMS**

- **1.3** milliards de fumeurs

- **1.7** milliard en 2020 - 2025.

Hommes: **1** milliard

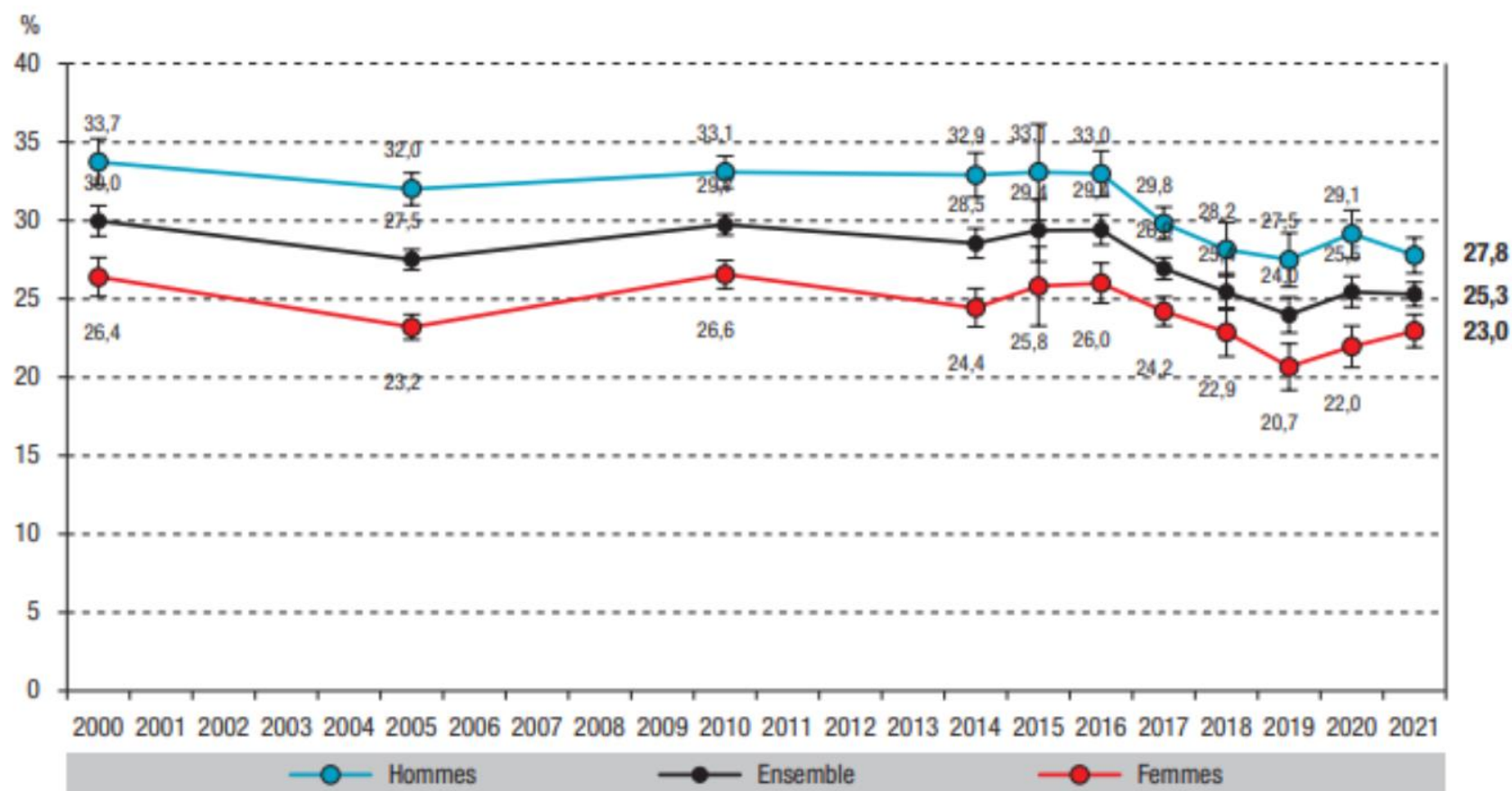
35% dans les pays développés

50% dans les pays en développement

- Femmes: **250** millions

22% dans les pays développés

9% dans les pays en développement



Sources : Baromètres de Santé publique France 2000, 2005, 2010, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Epidémiologie

- **Selon l'OMS**

- 5 500 milliards de cigarettes/année sont produites dans le monde pour une consommation d'environ 11 milliards de cigarettes/jour.

- En 2020, 22,3 % de la population mondiale consommait du tabac : 36,7 % des hommes et 7,8 % des femmes.

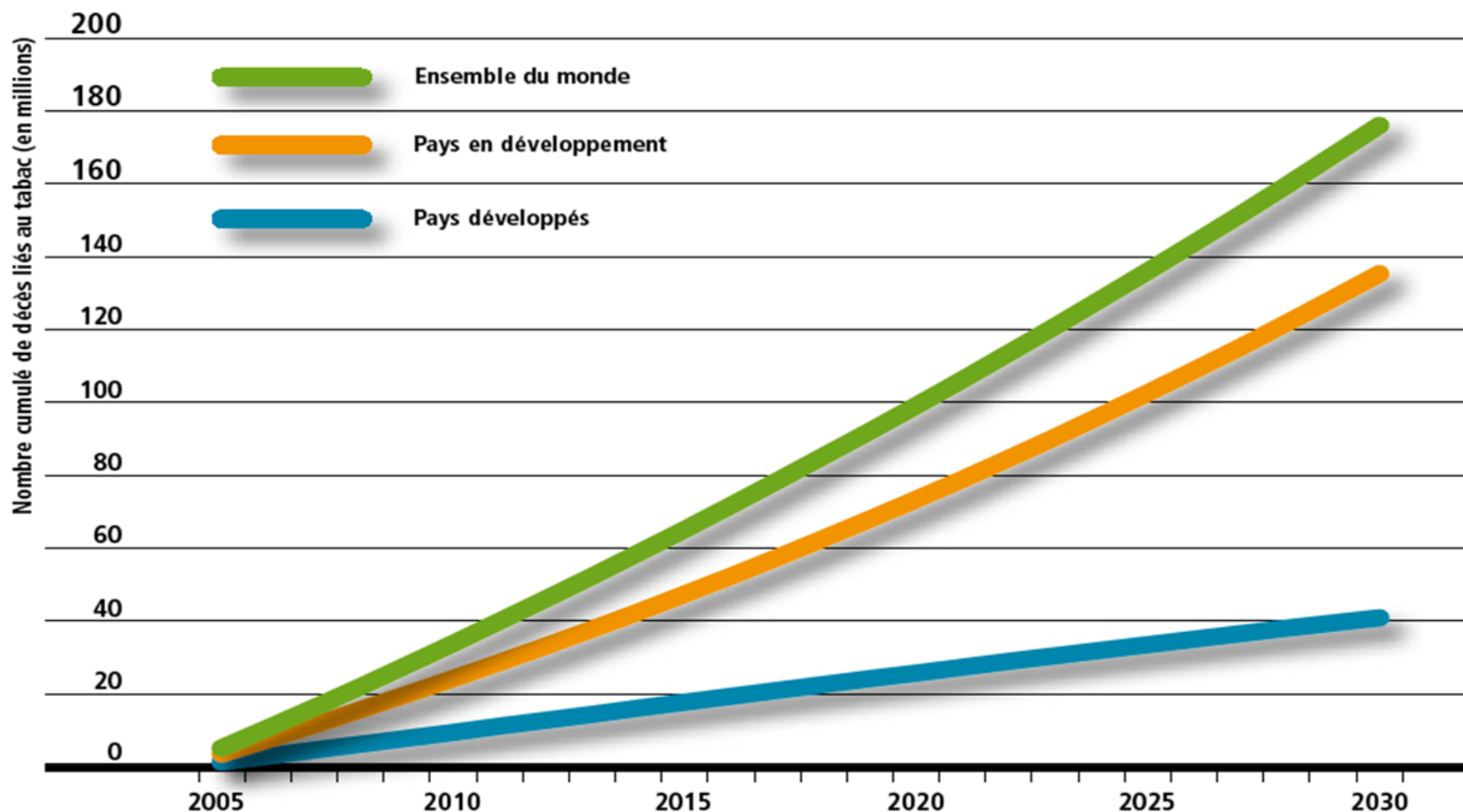
- >80 % vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire

Epidémiologie

- **Selon l'OMS**
- Un fumeur sur 2 meurt d'une maladie liée au tabac.
 - L'OMS estime que 8 millions de personnes meurent chaque année de l'usage du tabac, 1.2 million sont liés au tabagisme passif.
 - Ce chiffre atteindra 10 millions par an en 2030, avec 70% de morts dans les pays en développement.

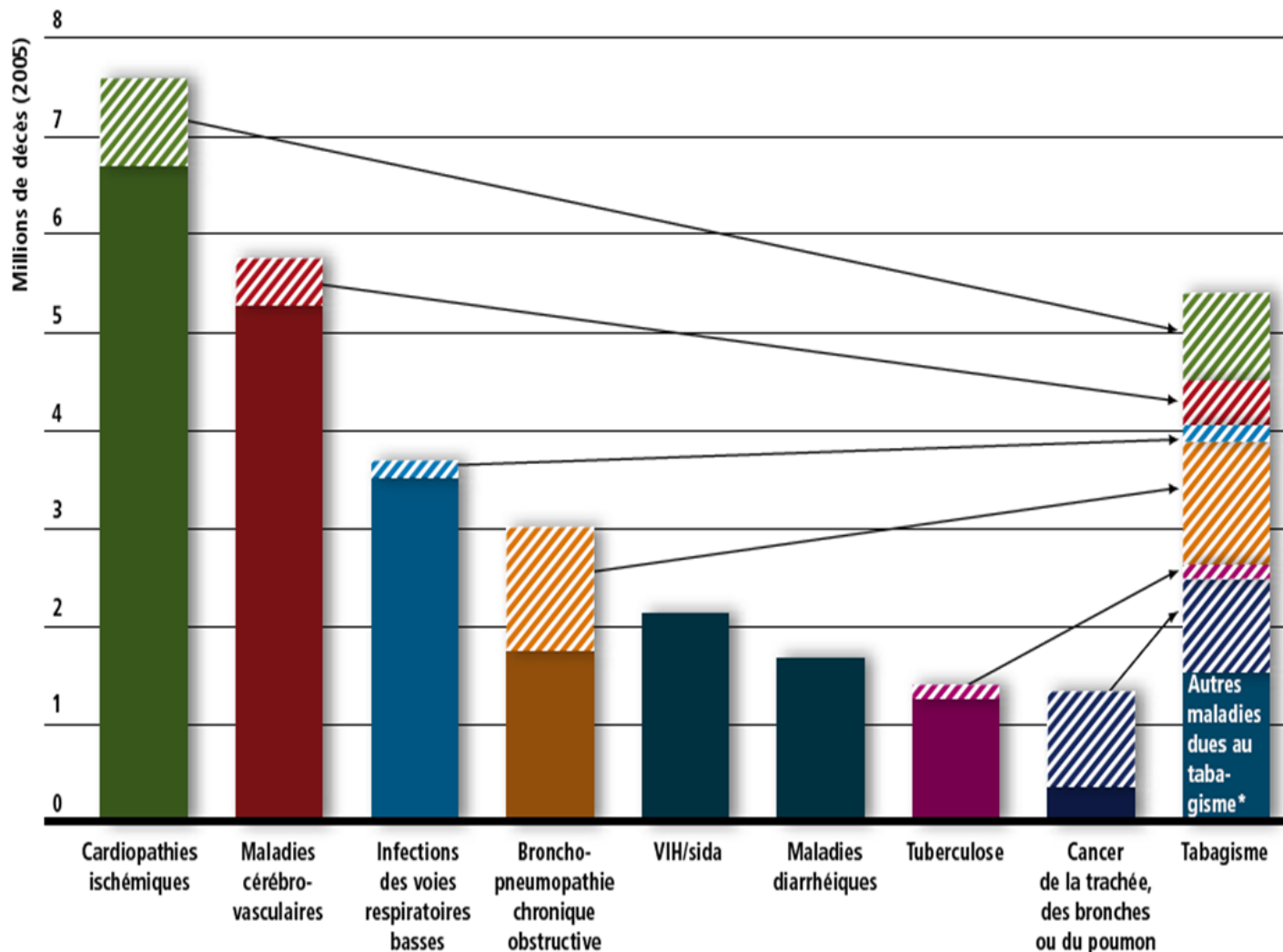
LE TABAGISME FERA PLUS DE 175 MILLIONS DE MORTS DANS LE MONDE ENTRE AUJOURD'HUI ET 2030

Nombre cumulé de décès liés au tabac, 2005-2030



Source : Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030.

LE TABAGISME EST UN FACTEUR DE RISQUE DE SIX DES HUIT PREMIERES CAUSES DE MORTALITE DANS LE MONDE



Les parties hachurées indiquent la proportion de décès liés au tabagisme. Elles sont de la même couleur que la colonne représentant la cause de mortalité correspondante.

* Cancer de la bouche et cancer oropharyngé, cancer de l'œsophage, de l'estomac, du foie, autres cancers et maladies cardio-vasculaires autres que les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébrovasculaires.

Source : Mathers CD, Loncar D, Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. *PLoS Medicine*, 2006, 3(11):e442. Informations supplémentaires obtenues par communication personnelle avec C. D. Mathers.

Source du chiffre révisé pour le VIH/sida : Le point sur l'épidémie de sida. Genève, Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2007.

Epidémiologie

En Algérie , le tabagisme est un grand pourvoyeur de maladies et de décès.

15000 morts/an imputés au tabagisme dont

- 7000 par IDM,
- 4000 par cancer bronchique
- 2000 par insuffisance respiratoire.

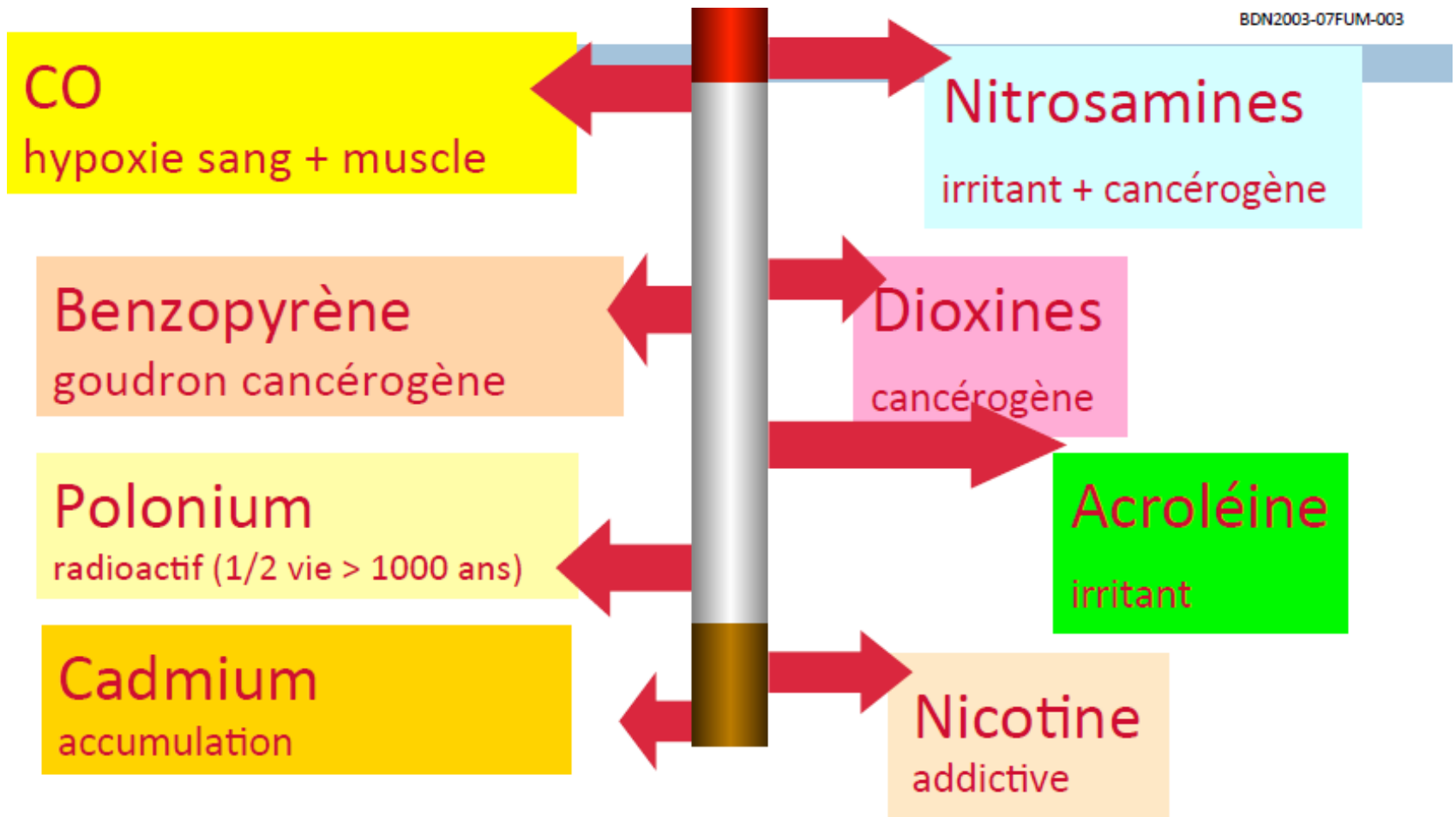
Epidémiologie

- L'enquête nationale de santé (projet TAHINA 2005) retrouve une estimation globale de 11 % parmi une population générale âgée de 35 à 70 ans.
- L'enquête réalisée à Alger par Nafti et col sur des élèves âgés de 6 à 20 ans retrouve 5,5% de fumeurs.
 - La consommation annuelle de tabac s'élève à 25000 tonnes, avec un accroissement annuel de 5%par an.
 - La consommation de tabac a triplé au cours de ces dernières décennies, 28% en 2005.

Composition

- Parmi les 4000 composants de la fumée du tabac, on retiendra principalement :
 - 1) **La nicotine** : qui engendre la dépendance physique et psychique. Elle est responsable d'effets vasculaires et neurologiques.
 - 2) **Les cancérigènes** : au moins 80 produits cancérigènes.
goudrons +++ : cancérigènes et irritants.
 - 3) **Les irritants**: tels les aldéhydes, les phénols ou l'acroléine...
ont une action sur l'appareil respiratoire
 - 4) **Le CO** : effets cardiovasculaires.
- NB/il est à noter que les cigarettes algériennes contiennent une **forte** teneur en produits toxiques dépassant largement les normes européennes.

Composition de la fumée (plus de 4000 composés)



Source: Reducing the health consequences of smoking: 25 years of progress. A report of the Surgeon General. Rockville, MD: US Department of Health and Human Services, 1989.

La fumée du tabac agit par 3 mécanismes :

- Sa température élevée,
- L'effet direct de la fumée sur les voies respiratoires
- Par passage dans le sang de certains composés

Composition de la fumée de cigarette

Il existe plusieurs courants de fumée :

- **Le courant principal (primaire)**
- **Le courant latéral (secondaire)**
- **Le courant tertiaire**

Les compositions de ces trois courants sont très différentes: **Le courant secondaire est plus toxique** que le courant principal inhalé par le fumeur

Quantification du tabagisme

- Age de début du tabagisme
- Importance actuelle du tabagisme
- Quantité totale de tabac fumé
- Durée du tabagisme

Les conséquences pathologiques en dépendent directement ; elle est estimée en « paquets-années ».

Les statuts tabagiques

Pour définir le statut fumeur d'un individu, il est conseillé de suivre les définitions suivantes :

- **Un non(jamais)-fumeur** est une personne ayant fumé moins de 100 cigarettes au cours de sa vie.
- **Un ex-fumeur (ou fumeur sevré)** a stoppé totalement et définitivement son tabagisme depuis plusieurs mois. Le délai le plus communément admis est 12 mois.
- **Un fumeur actif** est un fumeur non sevré depuis 12 mois.

La dépendance

- **La dépendance physique ou pharmacologique** est directement liée à la nicotine
- **La dépendance psychologique** est liée aux « effets positifs » que le fumeur associe à la cigarette.
- **La dépendance comportementale (ou sociale)** est liée aux situations répétées associées à la cigarette et qui peuvent déclencher l'envie « réflexe » de fumer

Examens para cliniques :

Testeur de Co : Il permet d'évaluer en ppm le Co et d'apprécier le niveau du tabagisme.

Il renforce la motivation en cours de sevrage.

Nicotinémie : sans intérêt en pratique courante.

Cotininémie.

Mesure du taux de CO expiré

Intérêt

- Marqueur du tabagisme : le taux de CO expiré est un bon reflet de l'intoxication tabagique récente (demi-vie de 6 h)
- Mesure très motivante : évaluation « visuelle » du tabagisme récent

Principe

- Inspiration profonde, puis apnée de 15 secondes, puis expiration à débit moyen, la plus prolongée possible ("en vidant totalement les poumons").
- La lecture se fait après la fin de l'expiration profonde dès que le chiffre se stabilise.
- La mesure se fait en partie par million (ppm)

Interprétation

- < 5 ppm : taux normal
- 5 à 15 ppm : intoxication modérée
- 15 à 30 ppm : intoxication importante
- > 30 ppm : intoxication très importante



Effets du tabac sur la santé

Tableau 2. Principales complications du tabagisme actif.

Types de complications	Caractéristiques des complications
Cancers	Poumons : le plus fréquent, lié au tabac dans 90 % des cas Autres : langue, larynx, pharynx, œsophage, rein, vessie, pancréas, estomac
Cardiovasculaires	Infarctus du myocarde augmenté, surtout avant l'âge de 45 ans Accident vasculaire cérébral (AVC), anévrisme de l'aorte, artérite des membres inférieurs
Respiratoires	Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) Aggravation d'un asthme préexistant
Reproduction	Impuissance chez l'homme Baisse de la fertilité chez la femme
Osseuses	Fractures pathologiques et d'ostéoporose post-ménopausique augmentées
Peau et phanères	Dessèchement de la peau, accentuation des rides, ongles et cheveux cassants
Infections	Infections bactériennes
Grossesse	Fausse couche, grossesse extra-utérine, retard de croissance du fœtus Faible poids de naissance

CANCERS

MALADIES CHRONIQUES

Larynx

Oropharynx

Oesophage

Trachée, bronches
ou poumons

Leucémie myéloïde aiguë

Estomac

Pancréas

Rein et urètre

Côlon

Col de l'utérus

Vessie

Accident vasculaire cérébral

Cécité, cataractes

Parodontite

Anévrisme de l'aorte

Cardiopathie coronarienne

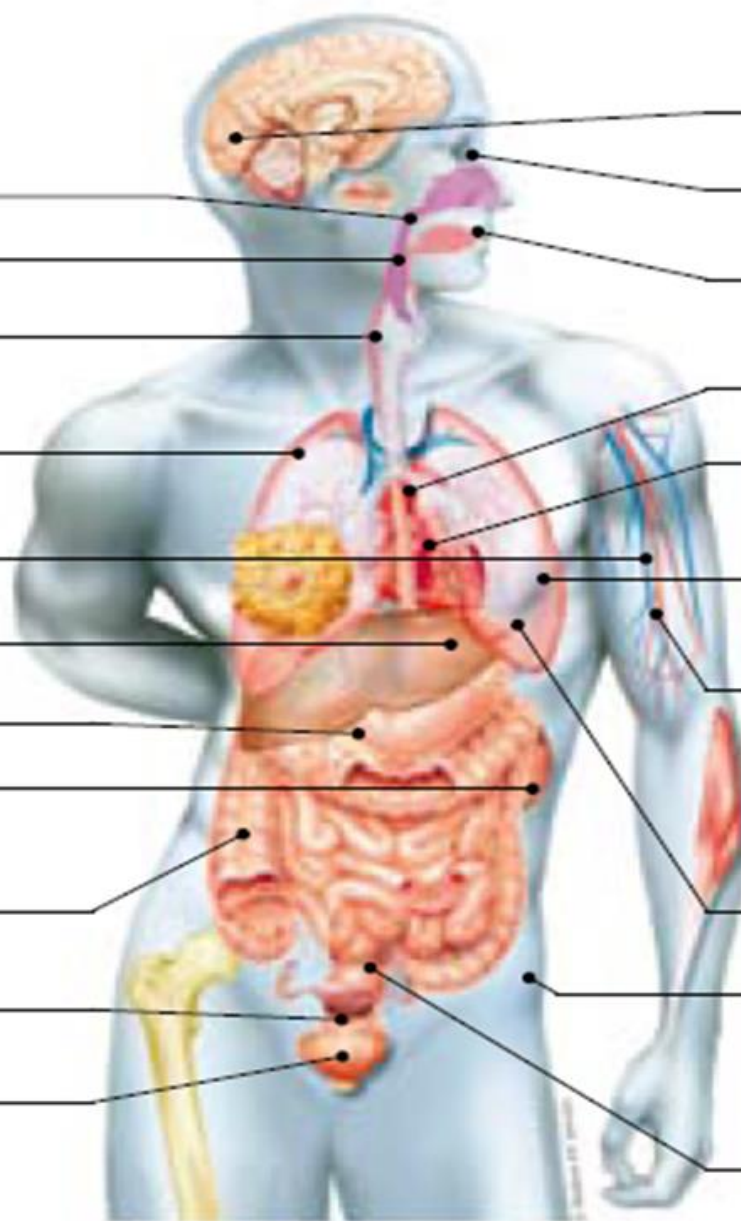
Pneumonie

Athérosclérose périphérique

Broncho-pneumopathie
chronique obstructive,
asthme et autres affections
respiratoires

Fractures de la hanche

Altération des fonctions de
reproduction chez la femme
(notamment baisse de la fécondité)



Tabagisme passif

Tableau 3. Principales complications du tabagisme passif.

Types de complications	Caractéristiques des complications
Risque cardiovasculaire	Principal risque Risque augmenté de 25 % pour un sujet vivant avec un fumeur
Cancer du poumon	Risque augmenté de 25 %
Risques sur le jeune enfant	Infections respiratoires, otites, asthmes Troubles déficitaires de l'attention, risque de dépression et d'anxiété généralisée

ENFANTS

Tumeurs du cerveau*

Infections de l'oreille moyenne

Lymphome*

Symptômes respiratoires, atteinte de la fonction respiratoire

Asthme*

Mort subite du nourrisson

Leucémie*

Infections des voies respiratoires basses

ADULTES

Accident vasculaire cérébral*

Irritations du nez, cancer des sinus*

Cancer du sein*

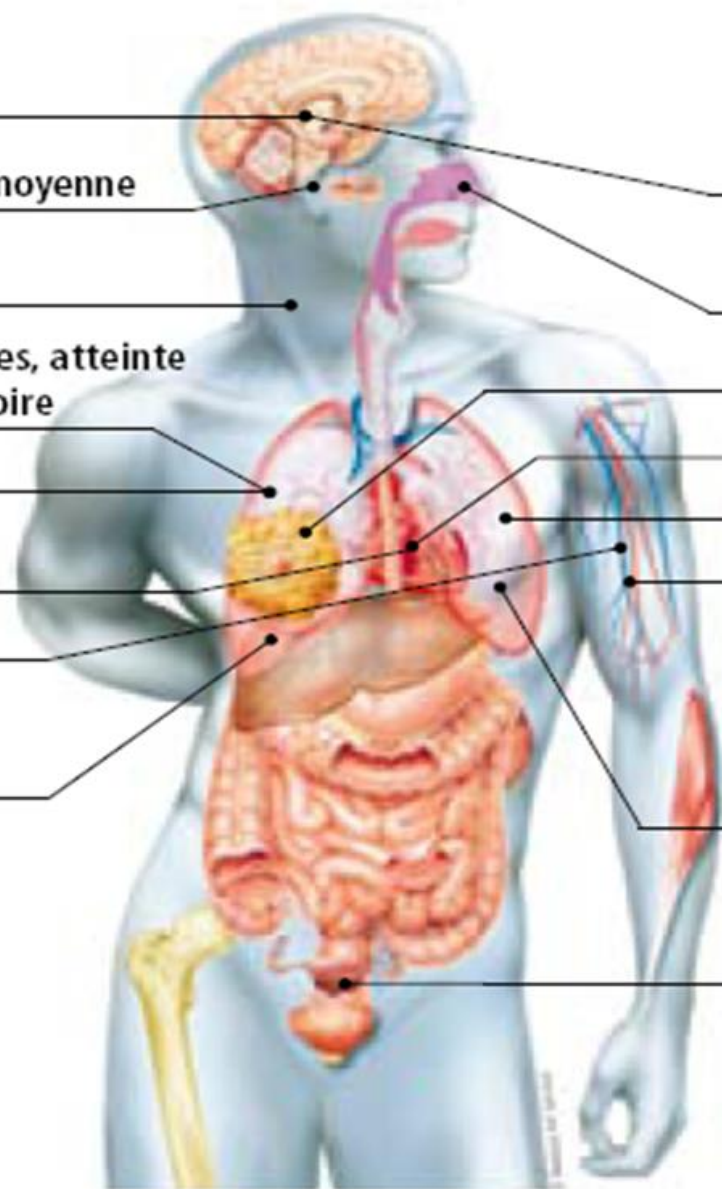
Cardiopathie coronarienne

Cancer du poumon

Athérosclérose*

Broncho-pneumopathie chronique obstructive*, symptômes respiratoires chroniques, asthme*, atteinte de la fonction respiratoire*

Altération des fonctions de reproduction chez la femme : faible poids de naissance ; accouchement prématuré*

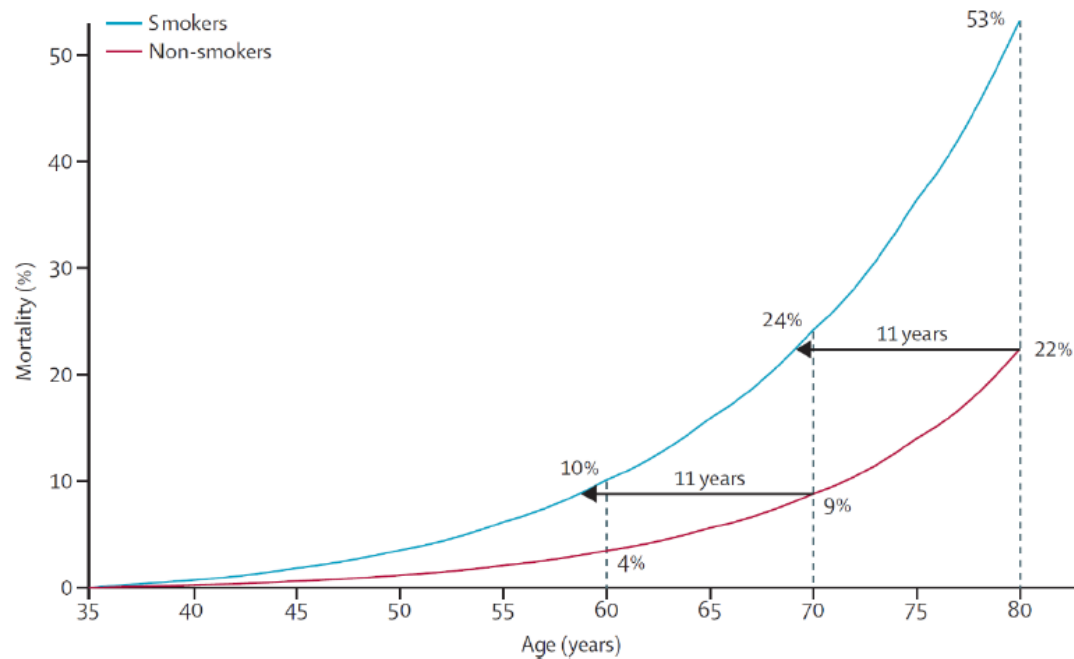


Tabagisme féminin

En plus des méfaits décrits chez l'homme on note :

- Accidents vasculaires cérébraux et Thrombophlébite si association fumée de tabac et oestroprogestatifs
- Hypofertilité.
- Accumulation de nicotine dans le lait maternel .
- Ménopause précoce.
- Cancer du col utérin.
- Raucité de la voix...etc.

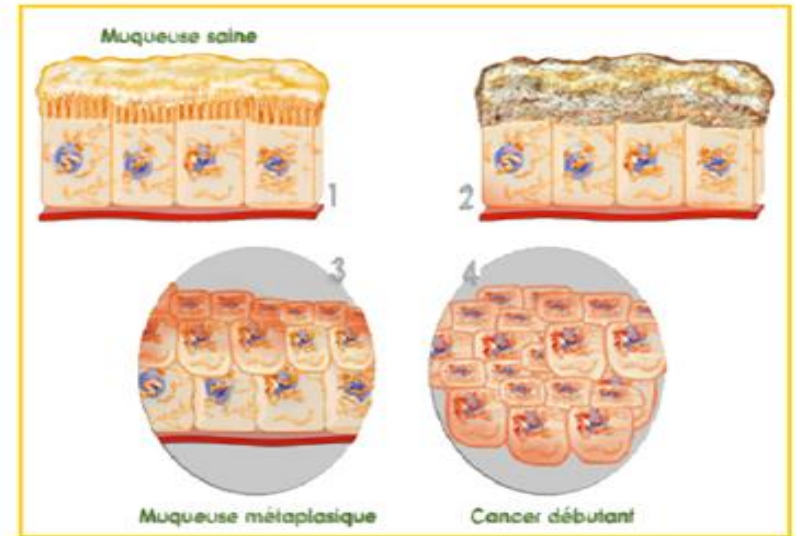
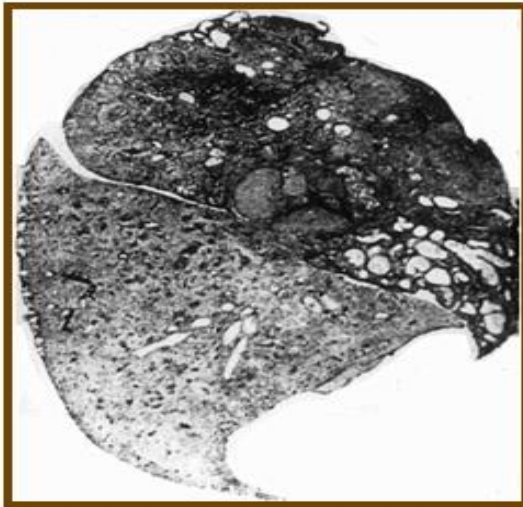
- 1,2 million de femmes suivies pendant 12 ans



Réduction de l'espérance de vie des femmes fumeuses de
presque 11 ans

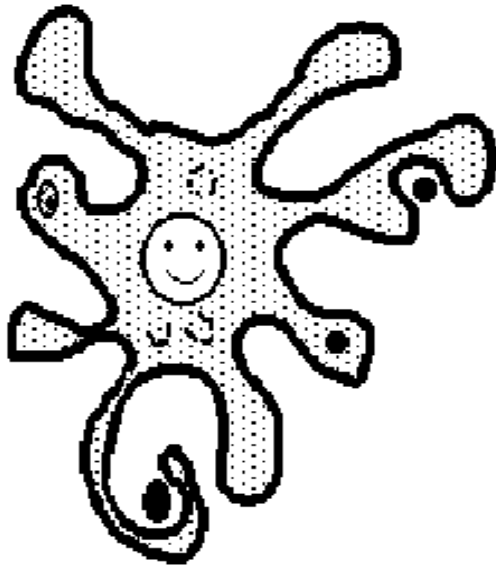
Pirie Lancet 2013

Le cancer du poumon

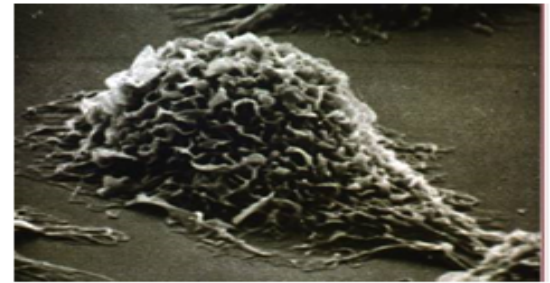


La muqueuse respiratoire est altérée progressivement par la fumée du tabac.

Les infections respiratoires



macrophage normal



macrophage de fumeur



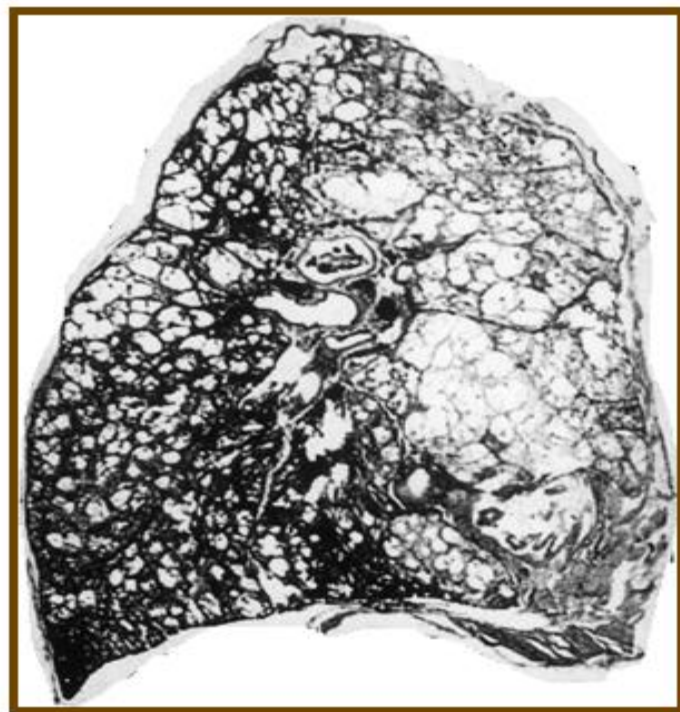
La fumée du tabac



Elastase des polynucléaires neutrophiles



destruction des fibres élastiques du
poumon

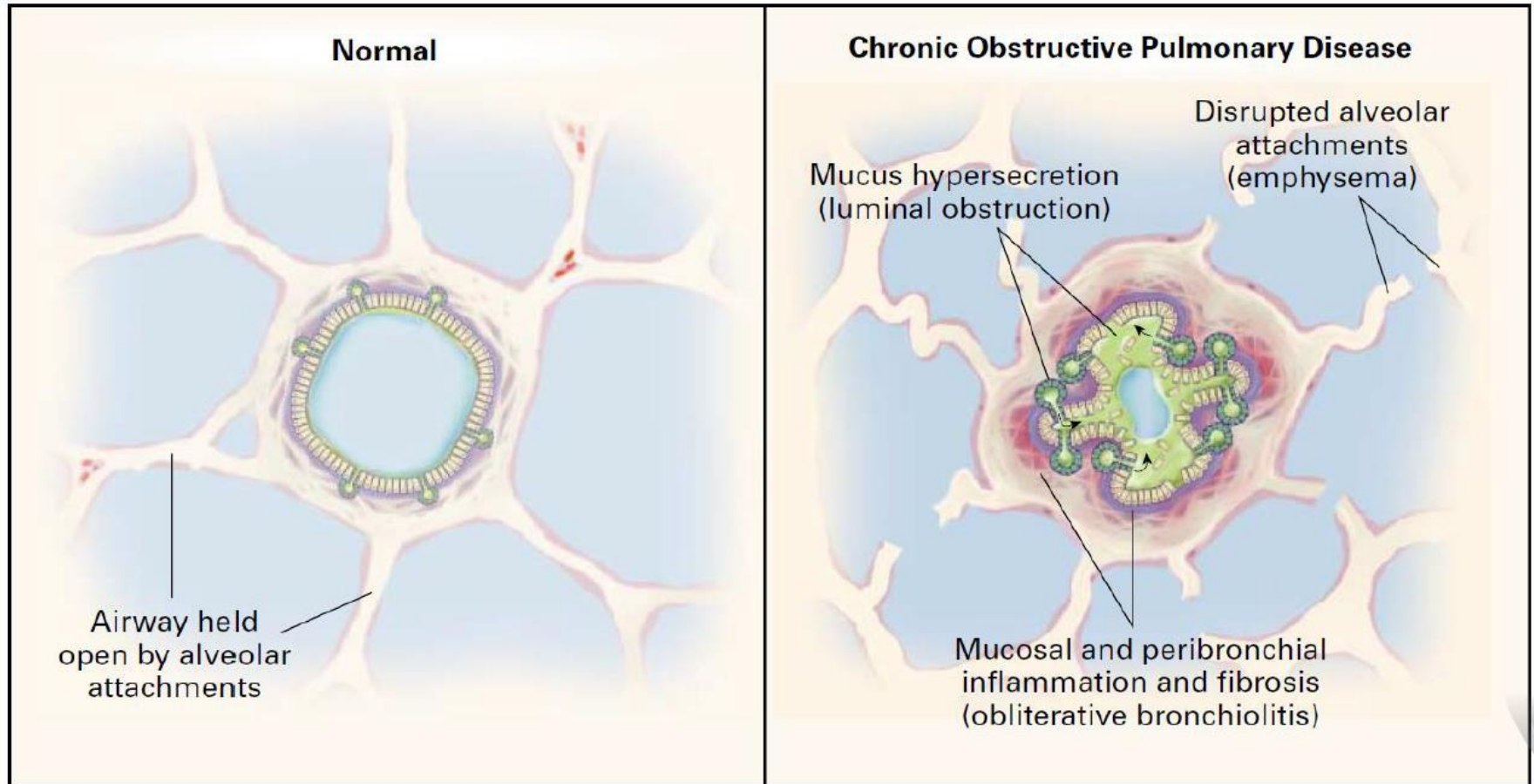


% de fumeurs développant une BPCO



BPCO
(15–25%)

Mécanismes de l'obstruction bronchique



Les effets de la fumée du tabac sur les bronches

A côté de la muqueuse, les parois bronchique se sont aussi altérées

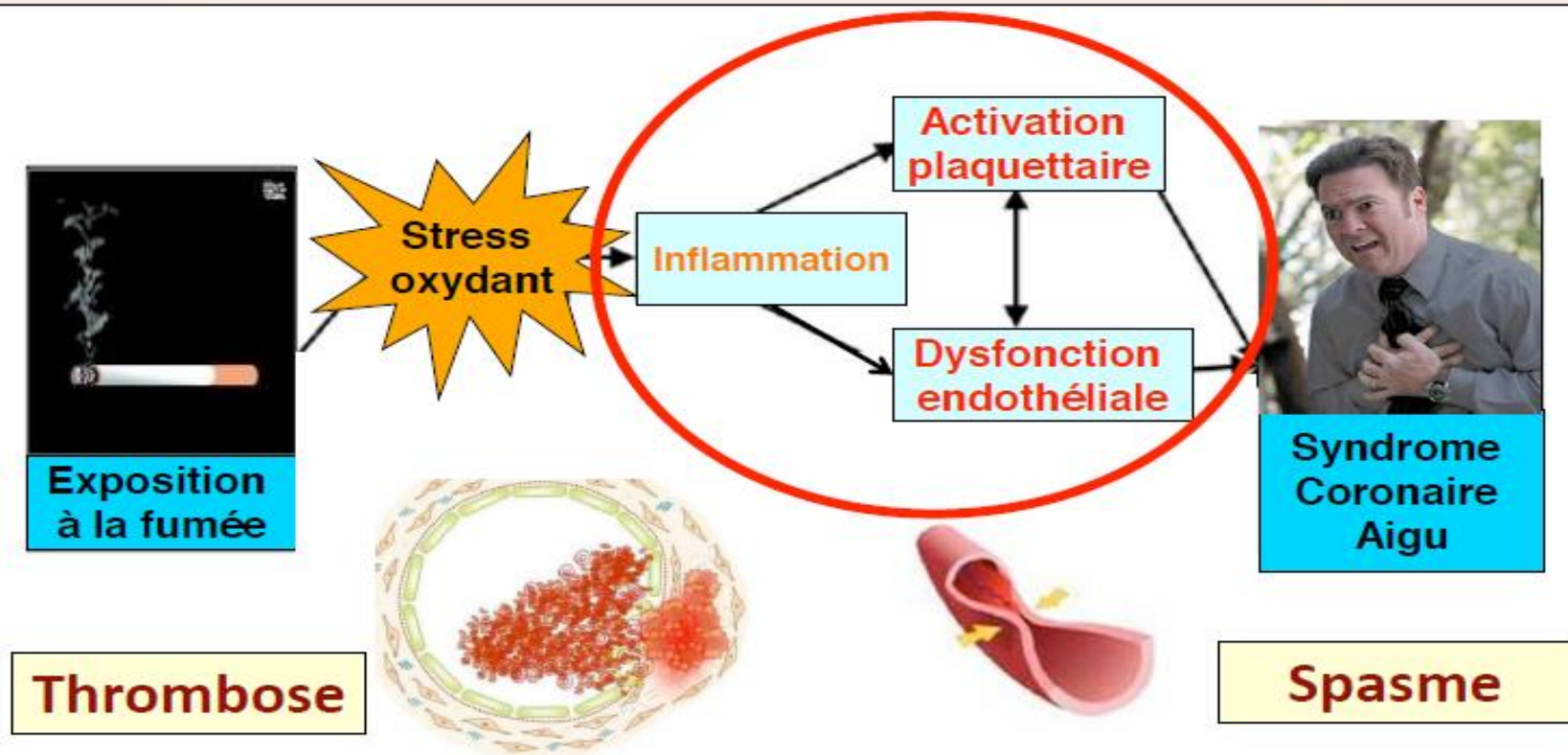
hypertrophie des glandes bronchiques

perte d'élasticité des muscles bronchiques

Toux +++

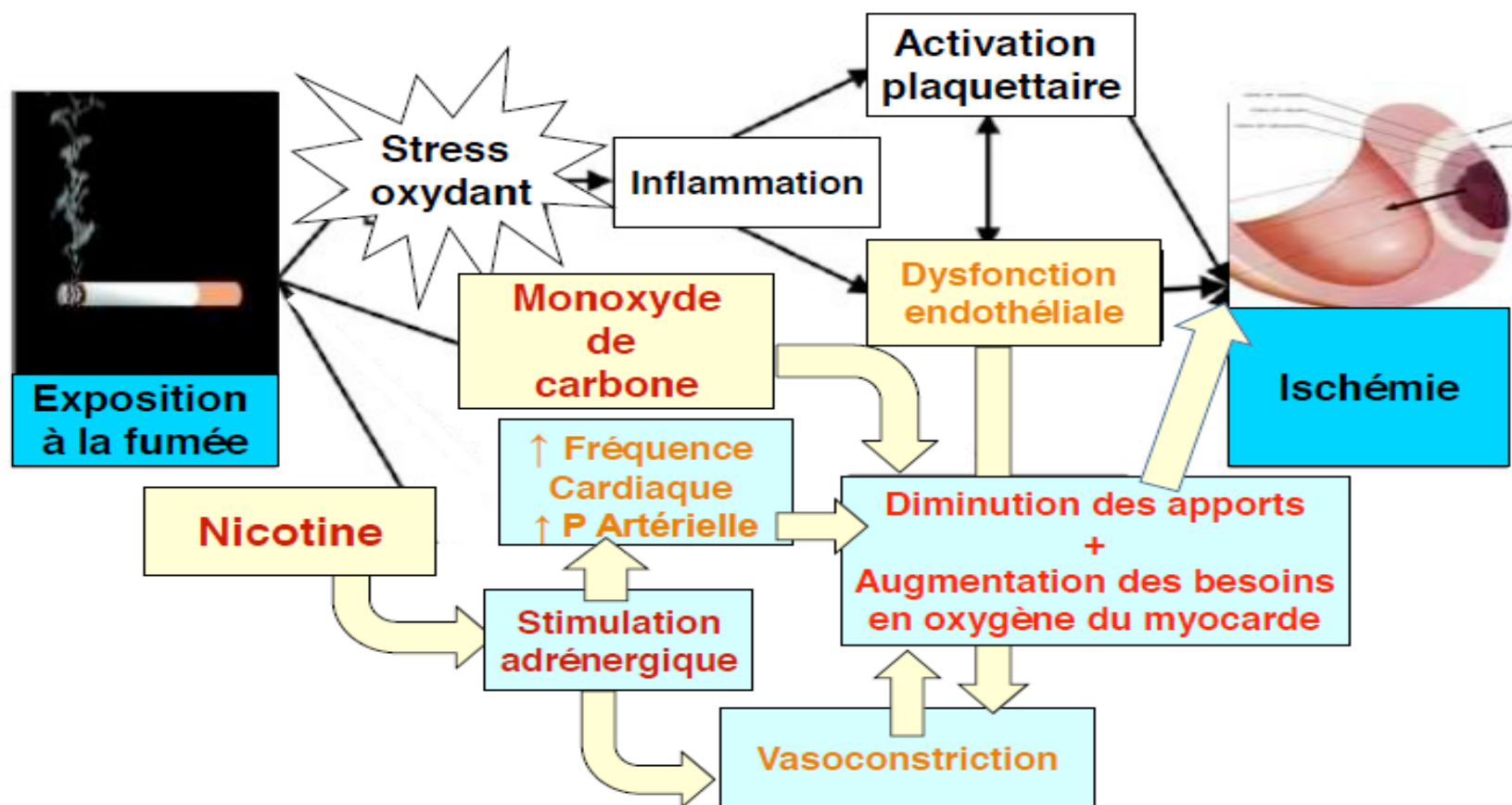


Tabagisme: facteur de thrombose et de spasme

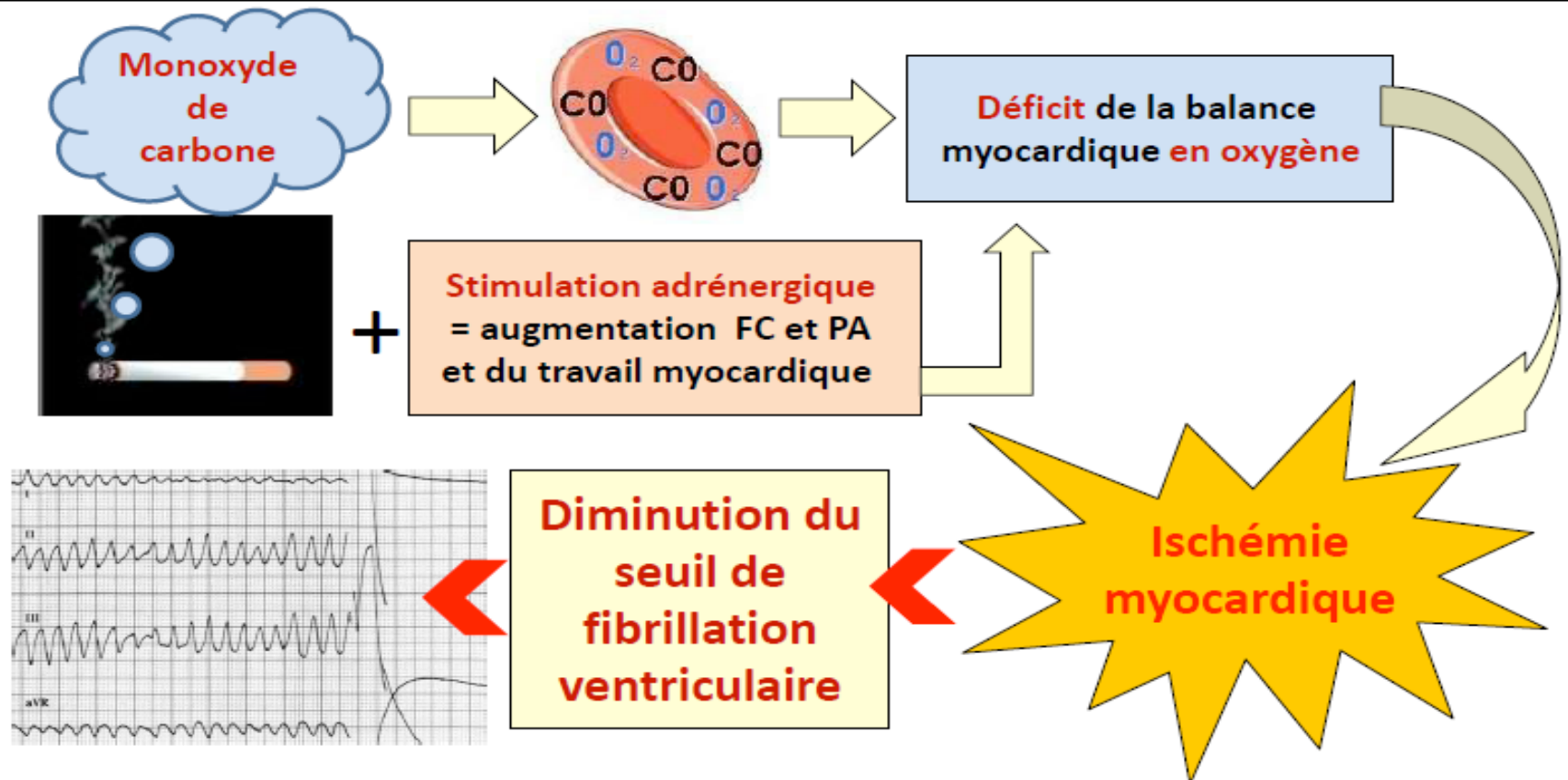


.... risque d' **accident coronaire aigu +++**

Tabagisme: facteur d'ischémie chronique

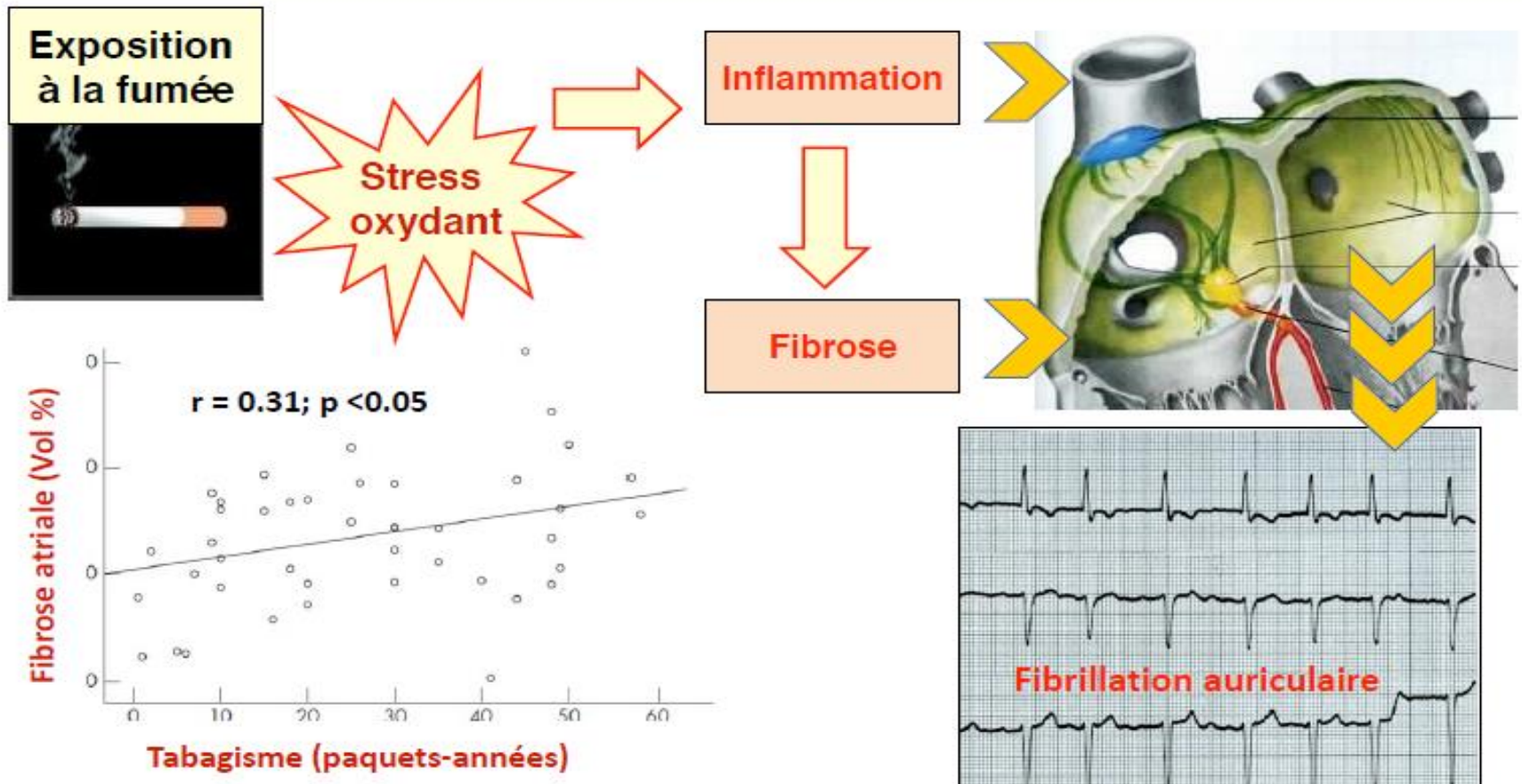


Troubles du rythme **ventriculaire**



Production of **arrhythmias** by elevated carboxyhemoglobin in **patients with coronary artery disease**

Troubles du rythme **auriculaire**



Dépendance

- C'est l'impossibilité de s'abstenir de consommer avec poursuite du comportement en dépit de la connaissance de ces effets délétères :
 - Dépendance gestuelle
 - Dépendance psycho comportementale
 - Dépendance pharmacologique
- En pratique et pour évaluer la dépendance on utilise un questionnaire : test de Fagerström

Dépendance

selon la CIM- 10, la dépendance est définie par la présence concomitante d'au moins trois des manifestations suivantes, au cours de la dernière année :

- Désir puissant ou compulsif d'utiliser la substance ;
- Difficulté à contrôler l'usage de la substance ;
- Syndrome de sevrage physiologique lorsque le sujet diminue ou arrête la consommation de la substance ;
- Mise en évidence d'une tolérance aux effets de la substance (le sujet a besoin d'une quantité plus importante de la substance pour obtenir l'effet désiré) ;
- Abandon progressif des autres sources de plaisir et d'intérêt au profit de la substance ; et augmentation du temps passé à se procurer la substance, la consommer ou récupérer de ses effets ;
- Poursuite de la consommation de la substance malgré la survenue de conséquences manifestement nocives.

Le test de dépendance à la nicotine de Fagerström 1991 (FTND : Fagerström Test for Nicotine Dependence)

Tableau 1 Test de dépendance à la nicotine (test de Fagerström - 1991) [67].

Questions	Réponses	Scores
1 - Dans quel délai après le réveil fumez-vous votre première cigarette ?	Moins de 5 minutes 6 à 30 minutes 31 à 60 minutes Après 60 minutes	3 2 1 0
2 - Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où c'est interdit ?	Oui Non	1 0
3 - Quelle cigarette trouvez-vous la plus indispensable ?	La première Une autre	1 0
4 - Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?	10 ou moins 11 à 20 21 à 30 31 ou plus	0 1 2 3
5 - Fumez-vous de façon plus rapprochée dans les premières heures après le réveil que pendant le reste de la journée ?	Oui Non	1 0
6 - Fumez-vous-même si une maladie vous oblige à rester au lit ?	Oui Non	1 0
Interprétation		
Score de 0 à 3 : peu ou pas de dépendance		
Score de 4 à 6 : dépendance moyenne		
Score de 7 à 10 : forte dépendance		
Score de 9 à 10 : très forte dépendance		

Syndrome de Sevrage tabagique

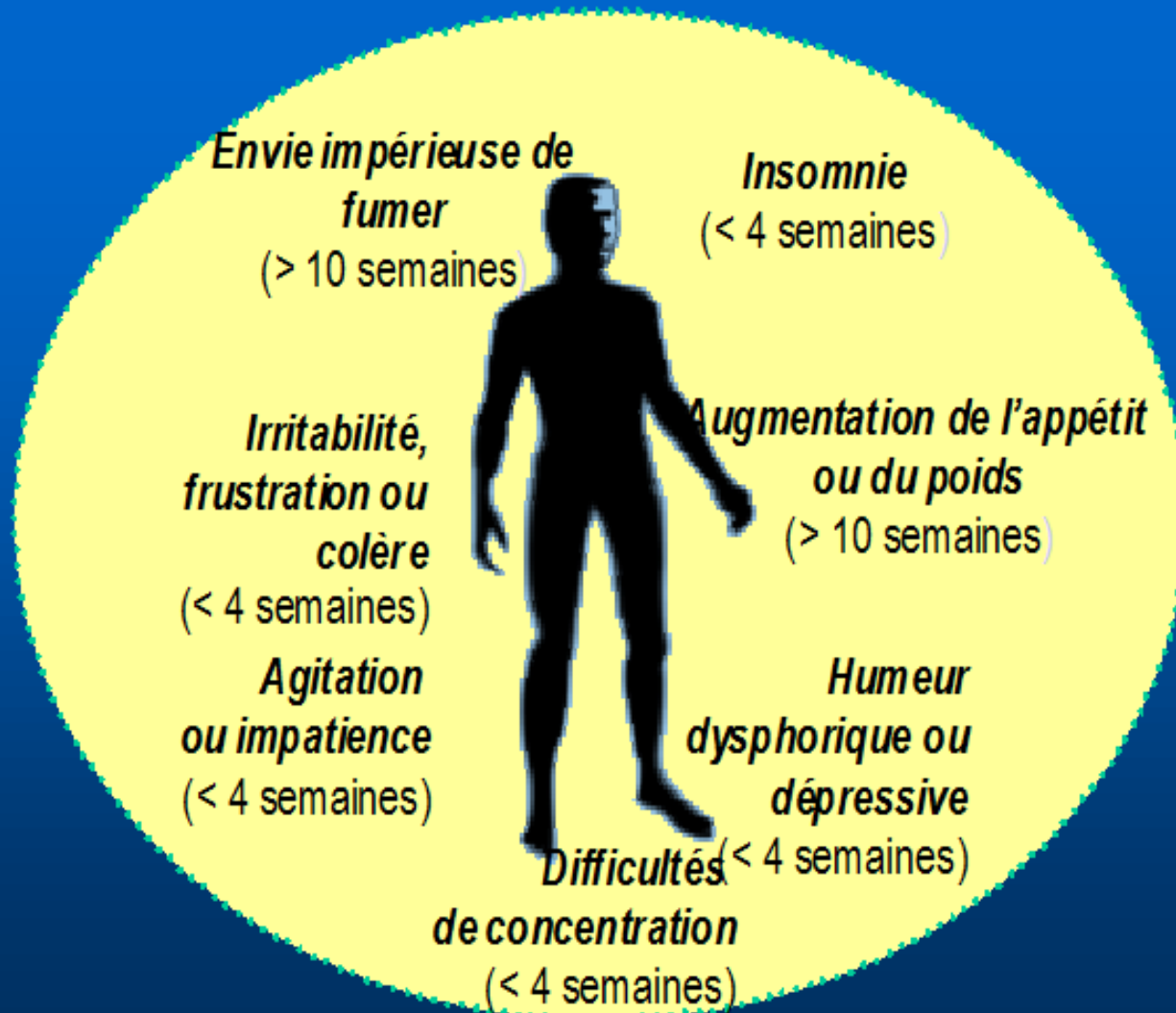
Présence d'au moins 4 des facteurs suivants :

- Humeur dépressive.
- Insomnie.
- Irritabilité, frustration, colère.
- Anxiété.
- Difficulté de concentration.
- Agitation.
- Ralentissement du pouls.
- Augmentation de l'appétit et/ou prise du poids rapide.

Ces signes causent une souffrance clinique et parfois une altération du comportement familial ou social.

Ils ne sont pas expliqués par une maladie mentale.

ensemble de troubles physiques et psychologiques rendant le sevrage difficile ^{15,16}



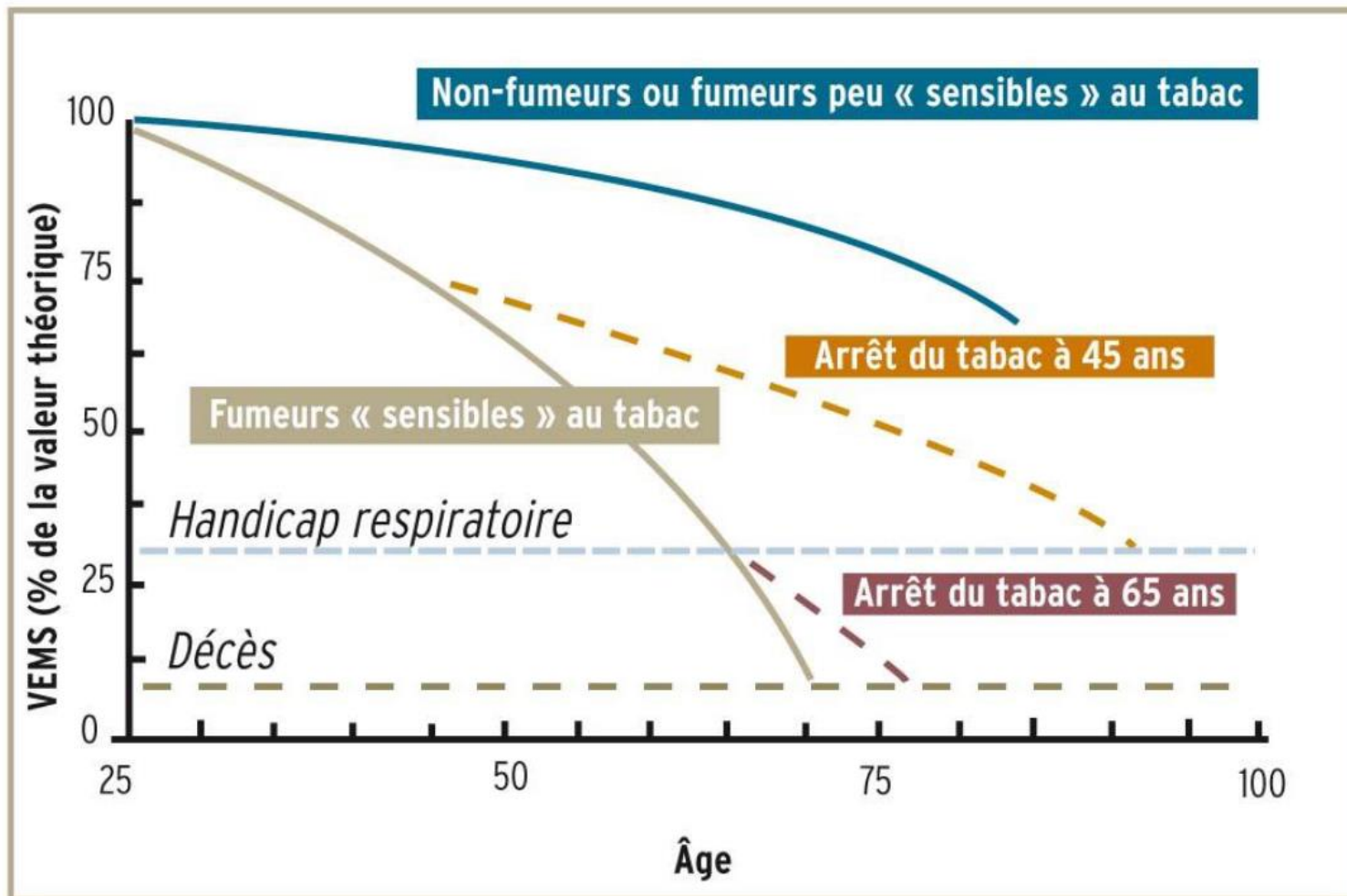
15- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington, DC: APA; 1994:242-247.

16- West RW, et al. Fast Facts: Smoking Cessation. 1st ed. Oxford, United Kingdom: Health Press Limited. 2004.

Bénéfices de l'arrêt du tabagisme

Arrêter de fumer Après 20 MINUTES	Après la dernière cigarette, la pression sanguine et les pulsations du cœur redeviennent normales.
Arrêter de fumer Après 8 HEURES	Après la dernière cigarette, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié.
Arrêter de fumer Après 24 HEURES	Après la dernière cigarette, les risques d'infarctus du myocarde diminuent. Les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée, le corps ne contient plus de nicotine.
Arrêter de fumer Après 48 HEURES	Après la dernière cigarette, le goût et l'odorat s'améliorent, les terminaisons nerveuses gustatives commencent à être réactivées.
Arrêter de fumer Après 72 HEURES	Après la dernière cigarette, respirer devient plus facile, les bronches commencent à se relâcher et on se sent plus énergique.
Arrêter de fumer Après 2 SEMAINES A 3 MOIS	Après la dernière cigarette, la toux et la fatigue diminuent. On récupère du souffle et on marche plus facilement. La circulation s'améliore rendant la marche et la course beaucoup plus facile.
Arrêter de fumer Après 3 A 9 mois	La toux, la respiration sifflante et les problèmes respiratoires disparaissent
Arrêter de fumer Après 1 A 9 MOIS	Après la dernière cigarette, les cils bronchiques repoussent, on est de moins en moins essoufflé.
Arrêter de fumer Après 1 AN	Après la dernière cigarette, le risque d'infarctus du myocarde diminue de moitié, le risque d'accident vasculaire cérébral rejoint celui d'un non fumeur.
Arrêter de fumer Après 5 ANS	Après la dernière cigarette, le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié.
Arrêter de fumer Après 10 ANS	Le risque de cancer du poumon diminue de moitié par rapport à un fumeur qui n'aurait pas arrêté. Le risque de maladie cardiaque est similaire à celui d'une personne qui n'a jamais fumé.
Arrêter de fumer Après 15 ANS	Le risque d'accident cérébro-vasculaire et le risque de cancer au poumon sont similaires à ceux d'une personne qui n'a jamais fumé. Après la dernière cigarette, l'espérance de vie redevient identique à celle d'une personne n'ayant jamais fumé.

Effets du tabagisme et du sevrage sur la fonction pulmonaire



Prise en charge de sevrage

- 03 étapes :

1. Evaluer et renforcer la motivation du patient:

- Conseil minimal + les bénéfices de l'arrêt

2. Le sevrage:

- Évaluation du degré de dépendance (Fagerström) et recherche d'autres toxicomanies et addictions
- Mesure du CO expiré
- Traitement substitutif

3. Prévention et prise en charge des rechutes:

- La rechute
- Trouble de l'humeur
- Prise du poids
- Consommation d'alcool



*Je ne veux pas arrêter.
Je suis content d'être fumeur,
cela me plaît, je suis bien.*

PAS PRET

*Médecin->donner un message court , (conseil minimal)
puis : si vous changez d'avis..*



*Je pense m'arrêter mais je ne suis pas
sûr d'être prêt pour le moment.
Médecin -->Nous allons en parler.*

hesitant

Médecin -->Voulez-vous en parler maintenant ?



*Je veux arrêter.
Il me faudra probablement de l'aide.
Il y a pour moi plus d'inconvénients que
d'avantages à continuer à fumer.*

Prêt

Médecin->Je peux vous aider à arrêter.



Non prêt :
Conseil minimal



Hésitant :
Interview
motivation



Prêt :
Aide au sevrage

Conseil minimal

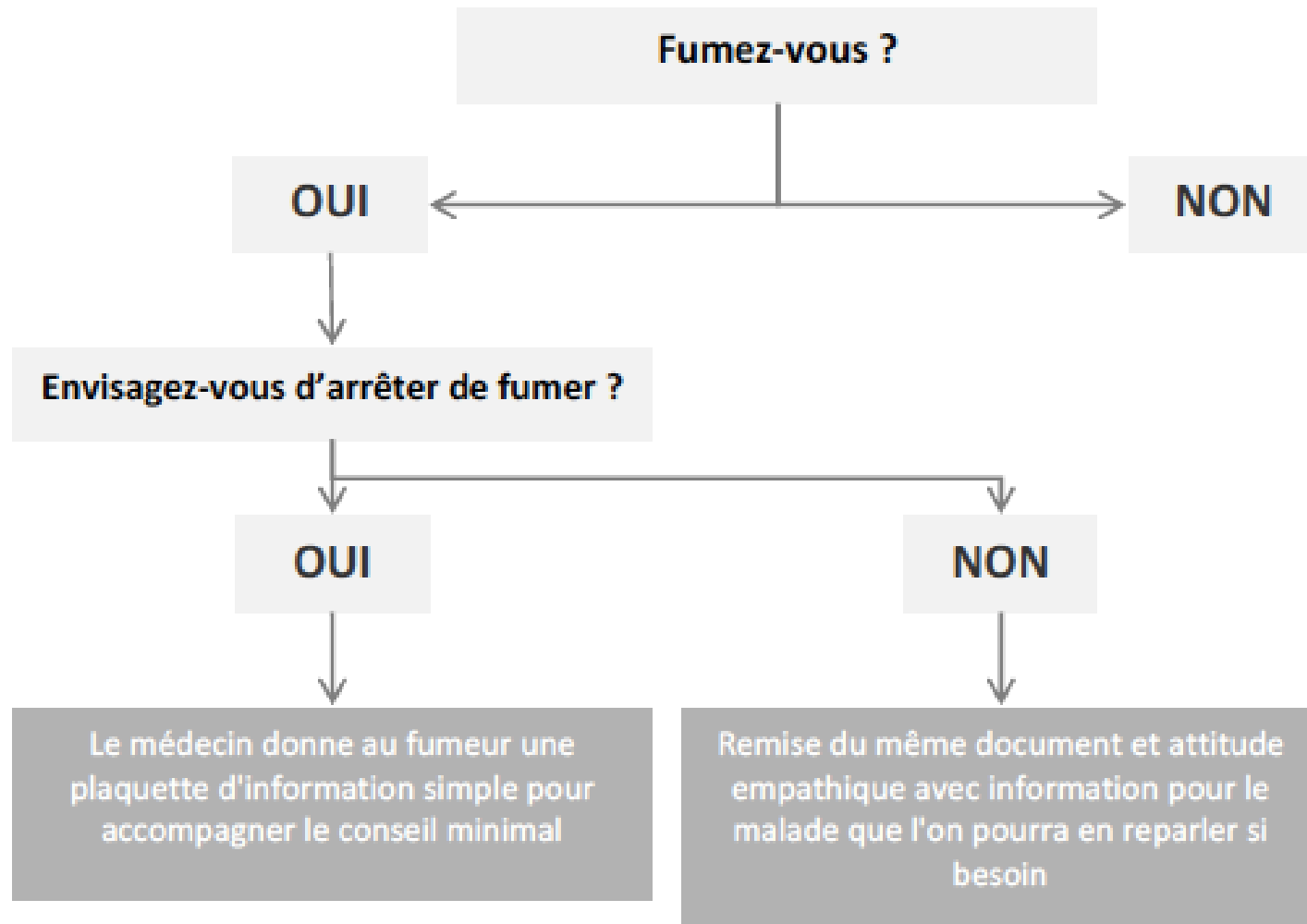


Tableau 3 Questionnaire d'évaluation de la motivation à l'arrêt du tabac (questionnaire Q-MAT) [75].

Questions	Scores
1 - Pensez-vous que dans six mois :	
Vous fumerez toujours autant ?	0
Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarettes ?	2
Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarettes ?	4
Vous aurez arrêté de fumer ?	8
2 - Avez-vous actuellement envie d'arrêter de fumer ?	
Pas du tout	0
Un peu	1
Beaucoup	2
Énormément	3
3 - Pensez-vous que dans quatre mois :	
Vous fumerez toujours autant ?	0
Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarettes ?	2
Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarettes ?	4
Vous aurez arrêté de fumer ?	6
4 - Vous arrive-t-il de ne pas être content(e) de fumer ?	
Jamais	0
Quelquefois	1
Souvent	2
Très souvent	3

Questionnaire d'évaluation de la motivation à l'arrêt du tabac (questionnaire Q-MAT)

Interprétation :

- Score ≤ 6 : Motivation insuffisante (faible chance de réussite : renforcer la motivation, nouvelle évaluation, réduction de la consommation aidée par des SN)
- Score de 7 à 13 : Motivation moyenne (renforcer la motivation, lever les craintes et les obstacles au sevrage, nouveau contact après réduction de la consommation aidée par des SN, évaluation)
- Score > 13 : Bonne ou très bonne motivation (sevrage tabagique)

Différents substituts nicotiniques

Tableau 4 Différents substituts nicotiniques commercialisés en France.

Formes galéniques	Noms de spécialité	Dosages
Dispositif transdermique (patch) de 24 heures	Nicotinell® Nicopatch® Niquitin®	21, 14 et 7 mg
Dispositif transdermique (patch) de 16 heures	Nicoretteskin®	25, 15 et 10 mg
Gomme à mâcher	Nicorette® Nicotinell®	2 et 4 mg 2 et 4 mg
Comprimé à sucer/pastilles	Nicotinell® Nicopass® Niquitin® Niquitinminis®	1 et 2 mg 1,5 et 2,5 mg 2 et 4 mg 1,5 et 4 mg
Comprimé sublingual	Nicorette Microtab®	2 mg
Inhalateur	Nicorette Inhaler®	Cartouche à 10 mg
Spray buccal	Nicorettespray®	1 mg/dose

	Total (N=1 034)
Utilisation d'une aide (au global)	47,7%
Cigarette électronique	26,9%
Substituts nicotiniques	18,3%
Recours à un médecin ou autre professionnel de santé	10,4%
Site Tabac info service	9,1%
Kit d'aide à l'arrêt du tabac	5,3%
Application Tabac info service	5,1%
Consultation de tabacologie	2,8%
Médicaments Zyban™ ou Champix™	1,1%
Ligne téléphonique 3989	0,9%

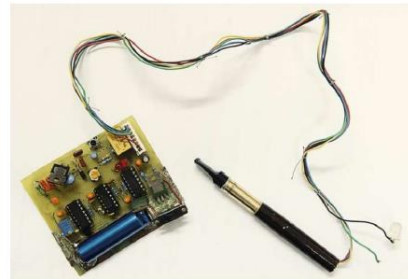
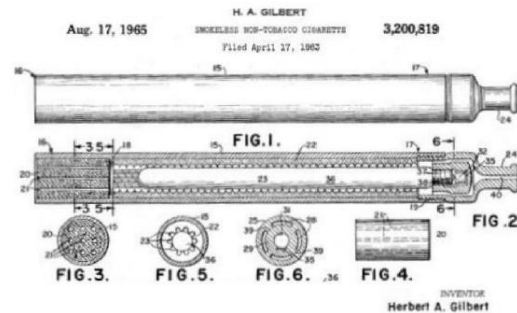
*Aides utilisées par HAS, 2013 les fumeurs ayant fait une tentative d'arrêt au dernier trimestre
2016, Guinard et al, BEH 2018*





De la cigarette électronique aux cigarettes électroniques

- Système électronique délivrance nicotine
- Invention en 1963
- Première commercialisation en 2009
- > 500 marques
- 3 générations



Que contient la cigarette électronique?



Propylène glycol

Glycérine végétale



Vapeur
Exhausteur de goûts

Eau

Arômes alimentaires ou de tabac:
> 7000

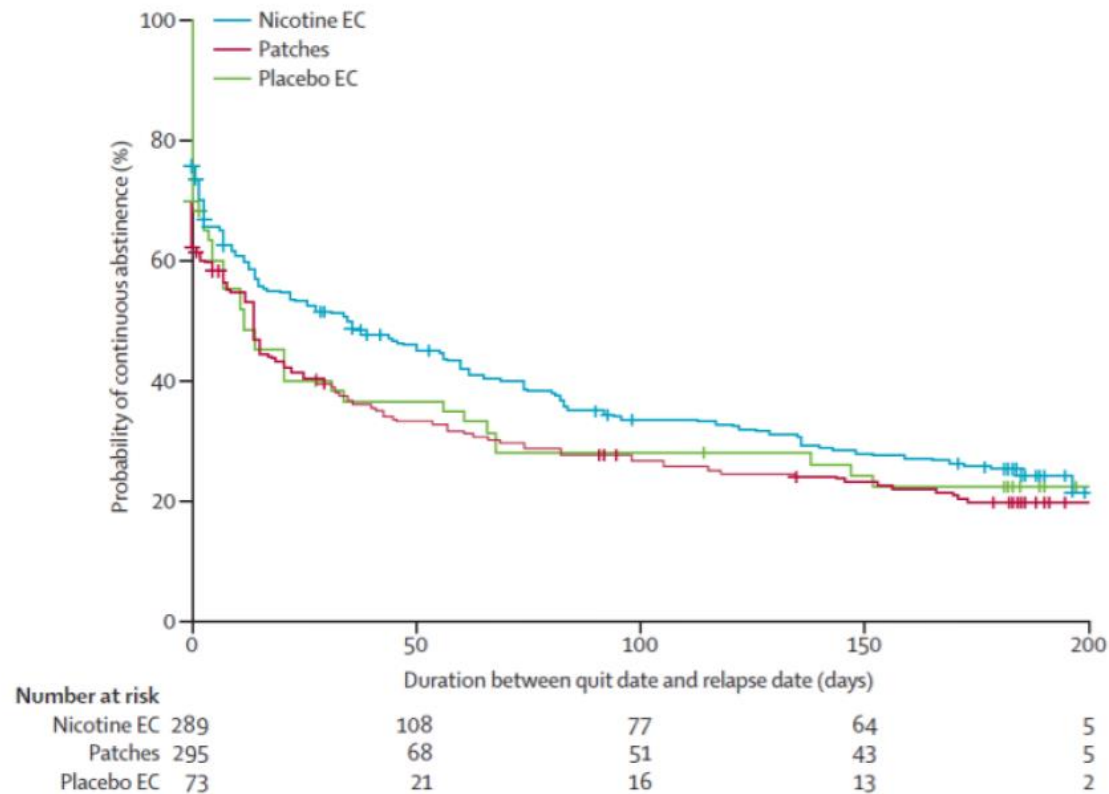
+/- Nicotine

Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial



Christopher Bullen, Colin Howe, Murray Laugesen, Hayden McRobbie, Varsha Parag, Jonathan Williman, Natalie Walker

Lancet 2013; 382: 1629-37

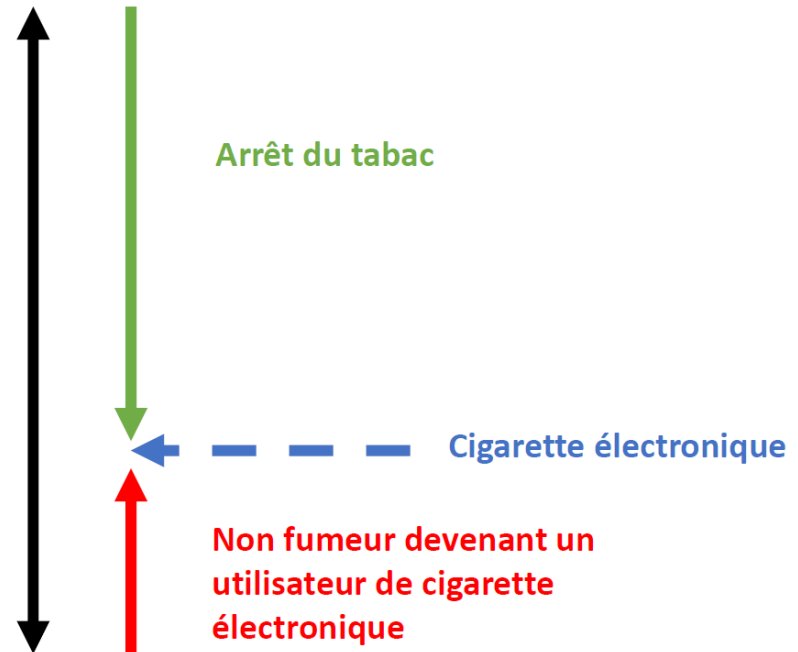


Utilisation de la cigarette électronique pour les fumeurs diminuent le risque sur la santé

Elle n'est probablement pas inoffensive sur la santé à long terme

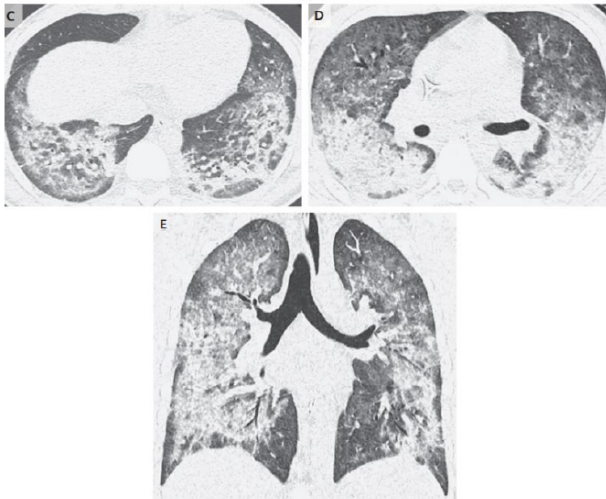
Besoin d'études à long termes sur les risques et effets secondaires

Risque sur la santé



Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin — Preliminary Report

Jennifer E. Layden, M.D., Ph.D., Isaac Ghinai, M.B., B.S., Ian Pray, Ph.D., Anne Kimball, M.D., Mark Layer, M.D., Mark Tenforde, M.D., Ph.D., Livia Navon, M.S., Brooke Hoots, Ph.D., Phillip P. Salvatore, Ph.D., Megan Elderbrook, M.P.H., Thomas Haupt, M.S., Jeffrey Kanne, M.D., Megan T. Patel, M.P.H., Lori Saathoff-Huber, M.P.H., Brian A. King, Ph.D., M.P.H., Josh G. Schier, M.D., Christina A. Mikosz, M.D., M.P.H., and Jonathan Meiman, M.D.



- 53 patients avec symptômes respiratoires et infiltrats bilatéraux
- Utilisation de la e cigarette dans les 90 jours
- 94% hospitalisés avec 32% d'intubation
- 15 patients ont présenté un SDRA
- Pas d'autres causes retrouvées que l'utilisation de e cigarette
- 84% des patients utilisaient des e cigarettes avec du THC
- Nature exacte des produits non connues (produits frelatés?)

Près de 1080 cas sont enquêtés aux Etats-Unis, par le Center of Disease Control, ayant entraînés 18 décès

Position des instances médicales



Afssaps/ANSM, mai 2011

Danger de la nicotine: ne pas utiliser les cigarettes électroniques

HAS, Reco 2013, revue en 2014:

« Ne pas recommander le recours à la E-cigarette, ms ne pas décourager ceux qui l'utilisent déjà » !

HCSP, avril 2014:

(Haut Conseil de Santé Publique)

- Faible efficacité
- Renormalisation du tabagisme

Février 2016: Est une aide au sevrage tabagique...

OMS, août 2014: Recommande restrictions d'utilisation, souligne les risques d'accidents, le danger pour les femmes enceintes, et la neuro-toxicité de la nicotine

2019: incontestablement nocive

OFT, avril 2014:

(Office Fr. contre tabagisme),

Recos de médecins spécialistes:

- Utilité de la E-cigarette ds le sevrage
- Préconisations pratiques pour les médecins

Académie de médecine, mars

2015: Souhaite l'émergence d'une E-cigarette « médicament » ! Et son remboursement

CIGARETTE ÉLECTRONIQUE : PRUDENCE ET VIGILANCE

© mediaphotos / Stock.com



Pour en savoir plus
sur les cas d'atteintes
pulmonaires
chez des utilisateurs de
e-cigarette aux USA :

Communiqué de
La Fondation du Souffle et de
la Société de Pneumologie
de Langue Française

Note du Groupe tabac de
la Société de Pneumologie
de Langue Française



Prévention et lutte anti tabac

- 1. Prévention** : a pour objectif d'obtenir la diminution du pourcentage de fumeurs dans la population adulte et d'empêcher le début du tabagisme chez l'enfant et l'adolescent.
 - 2. lutte anti-tabac** : c'est un but difficile à atteindre quel que soit le pays car cette lutte fait appel à la bonne volonté de plusieurs catégories de profession.
- L'efficacité de cette lutte ne peut être espérée que si elle s'exerce parallèlement à trois niveaux :

I. lutte au niveau individuel :

- Informer sur les effets nocifs du tabac.
- Supprimer la dépendance pharmacologique.
- Agir sur la dépendance psychosociale.

2. lutte au niveau collectif:

- Le milieu professionnel.
- Le milieu scolaire.

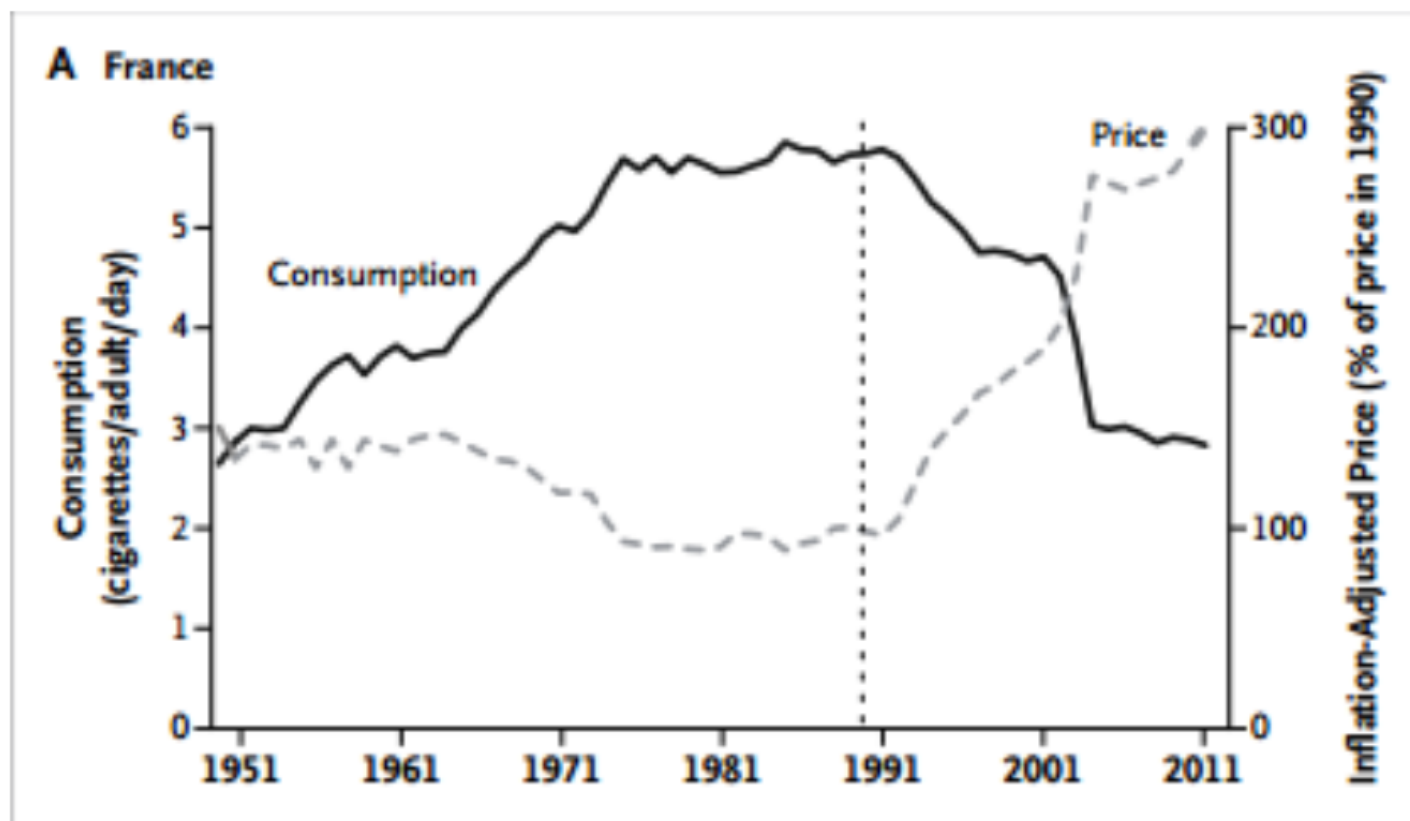
3. au niveau législatif:

Augmentation des taxes et des impôts....prix des cigarettes.

publicités interdites,

Séparation : coins fumeurs et non fumeurs dans les lieux publics.

Evolution de la consommation de tabac en fonction de l'évolution du prix des cigarettes en France (Prabhat J, NEJM 2014).



- Loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la

santé dans ses articles (63,64,65,66) :

Porte sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics, la publicité, l'éducation sanitaire et l'avertissement sanitaire

- Arrêté n° 24 MSP/ MIN du 15 juillet 1999 portant création du comite médical

national de lutte anti-tabac .

- Le comite est chargé de :

Faire des propositions et recommandations en vu de l'élaboration d'un programme de lutte contre le tabagisme.

Proposer un programme de formation et de recyclage du personnel susceptible de prendre en charge le dossier.

Proposer toutes mesures susceptibles de faciliter l'application du programme.

Participer à la supervision et l'évaluation des différentes activités du programme.

- Décret exécutif N°01-285 du 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l'usage du tabac est interdit et les modalités d'application de cette interdiction

Les lieux publics sont bien définis avec des dispositions particulières au tabac à fumée, avec signalisation apparentes et mesures de protection des non fumeurs, avec recours aux sanctions

Décret exécutif N° 01-396 du 9 décembre 2001

Portant sur la fabrication et la distribution de tabacs, la comptabilité, les prix des produits tabagiques, l'importation du tabac et des produits tabagiques, les conditions de prévention sanitaire .

Décret exécutif N° 01-397 du 9 décembre 2001

Fixant les conditions d'importation des tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant d'un agrément en qualité de fabricant de tabacs et portant sur la réglementation à laquelle sont soumis les fabricants du tabac .

Instruction N°001 du 10 mars 2002 Mise en œuvre des dispositions du décret du 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l'usage du tabac est interdit et les modalités d'application de cette interdiction.

Décret exécutif N°02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale N°302-096 intitulé "Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux"].

Arrêté du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002

Fixant les modalités spécifiques d'application au secteur de la jeunesse et des sports des dispositions du décret exécutif N°01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l'usage du tabac est interdit et les modalités d'application de cette interdiction .

Arrêté du 4 safar 1424 correspondant au 6 avril 2003 mettant des emplacements à la disposition des fumeurs dans certains lieux du secteur de la communication et de la culture où l'usage de tabac est interdit .

Instruction ministérielle N°1437/MSPRH/DP/2005:

Relative à la mise en application du décret exécutif n° 01-285 du 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l'usage du tabac est interdit et les modalités d'application de cette interdiction.

Décret présidentiel N°06-120 du 12 mars 2006 :

Portant ratification de la convention adoptée à Genève le 21 mai 2003.

Circulaire ministérielle N°020 MSPRH/MIN du 23 mai 2007 relative à la mise en application du décret exécutif N° 01-285 du 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l'usage du tabac est interdit et les modalités d'application de cette interdiction.

Instruction N°1035 DP/MSPRH du 02 juin 2007 relative à la mise en application du **décret exécutif N° 01-285 du 24 septembre 2001**, fixant les lieux publics où l'usage du tabac est interdit et modalités d'application de cette interdiction et conformément à la circulaire ministérielle du 020 du 23 mai 2007.

Décision ministérielle N° 2389 du 08 décembre 2007, fixant la liste nominative du Comité National de Lutte contre le Tabac.

Conclusion

- Le tabagisme est un comportement acquis à l'adolescence, entretenu et renforcé par une dépendance
- Il est la cause de multiples maladies (Cancers-AVC-BPCO-...).
- On assiste actuellement à un rajeunissement de l'âge de début et la féminisation du tabagisme.

Conclusion

- Le tabac est la première cause de mortalité prématurée et de morbidité évitable.
- La mortalité due au tabagisme augmente dans le monde entier mais surtout dans les pays en voie de développement.
- Le médecin doit être conscient des méfaits du tabagisme et participer activement pour lutter contre ce fléau mondial